

2019 traduit

1. Un patient de 23 ans se rend chez son médecin de famille pour des saignements de nez récurrents. La rhinoscopie a révélé une perforation septale. Quelle est la principale chose à laquelle il faut penser ?

- a) Diathèse hémorragique aiguë
- b) La granulomatose de Wegener
- c) L'hypertension artérielle
- d) Lymphome
- e) la consommation de cocaïne

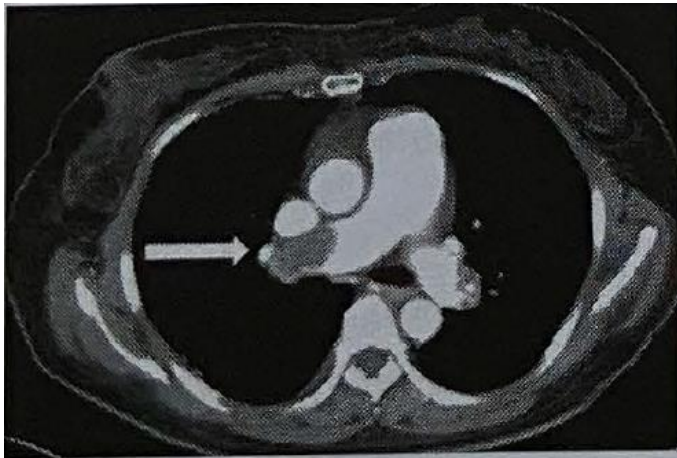
2. Un patient de 60 ans connu pour une artériosclérose et le status post pontage coronarien a maintenant une TA de 155/97 mmHg 2 ans après l'opération, malgré une trithérapie antihypertensive (valeur précédente 137/82). Une sténose unilatérale de l'artère rénale de 50 %, et la créatinine est toujours normale. Quelle thérapie n'est pas indiquée ?

- a) Restriction concernant le sel
- b) Dilatation de la sténose des artères rénales
- c) 15 mn d'exercices d'aérobic par jour
- d) Optimisation d'une éventuelle hypercholestérolémie

3. Une femme enceinte à la 36 4/7 SA vient avec une nouvelle hypertension artérielle. Quelle est la dernière chose que vous voulez lui donner ?

- a) Inhibiteurs de l'ECA
- b) Les bêta-bloquants
- c) antagoniste du calcium
- d) Le magnésium

4. Un homme de 46 ans se présente aux urgences avec une dyspnée aiguë. Les résultats d'une angio CT sont les suivants. Quelle est la cause la plus probable ?



- a) Embolie pulmonaire
- b) Pneumonie
- c) L'épanchement pleural
- d) Tamponnade péricardique
- e) la tuberculose pulmonaire

5. Une femme enceinte se présente avec des douleurs abdominales basses aiguës. Aux urgences, on suspecte une appendicite. Cependant, l'échographie abdominale non concluante. Quelle est la prochaine étape en matière d'imagerie ?

- a) CT avec PC
- b) CT sans PC
- c) IRM avec PC
- d) IRM sans PC
- e) ASP

6. Un patient de 27 ans connu pour un asthme bronchique se présente à son médecin de famille avec une sensation d'oppression thoracique après l'exercice et des réveils nocturnes une ou deux fois par semaine en raison de difficultés respiratoires. La thérapie par inhalation prescrite par le médecin de famille n'est pas appliquée de manière fiable. Le débit de pointe est de 76% de la meilleure valeur prédite. Il n'y a aucun signe d'infection des voies respiratoires supérieures.

Le traitement consiste en un bêta-mimétique :

- a) comme seule thérapie
- b) et un anticholinergique inhalé
- c) et un stéroïde à inhaler
- d) et un antagoniste des leucotriènes
- e) et un stéroïde oral

7. Une femme de 19 ans se présente à une consultation gynécologique pour une contraception parce qu'elle a un nouveau partenaire. En consultant le carnet de vaccination, on constate que sa couverture vaccinale est incomplète. Le statut du ROR n'est pas documenté et n'est pas clair. Quelle est la prochaine étape ?

- a) la vaccination 1 dose
- b) 2 doses la vaccination, à 4 semaines d'intervalle
- c) vaccination 1 dose, contrôle sérologique après 4 semaines, en fonction des résultats 2^{ème} vaccination
- d) pas de vaccination
- e) contrôle sérologique, en fonction des résultats Vaccination

8. Une patiente de 46 ans souffrant de douleurs dans le haut de l'abdomen, qui irradient principalement dans l'hypogastre gauche, se présente dans son cabinet de médecine générale. La douleur existe depuis la veille. La patiente fume et boit de l'alcool régulièrement. L'abdomen est mou, avec une douleur de pression dans le haut de l'abdomen. Sans détente. L'échographie ne montre aucun signe de cholécystite ou de calculs dans les voies biliaires.

Laboratoire : Hb 94, Lc 14, CRP 70, Tc normal. AP, GGT, bilirubine élevées. Amylase, lipase élevées. Quel est votre diagnostic provisoire ?

- a) Ulcère gastrique
- b) Diverticules duodénaux
- c) la pancréatite biliaire
- d) perte tardive de calculs biliaires
- e) la pancréatite alcoolique

9. Une patiente de 82 ans se présente aux urgences avec des douleurs abdominales diffuses croissantes depuis 6 heures. Maintenant, la douleur est devenue très intense. Auparavant, on connaissait une dyslipidémie, la DM2 et l'hypertension artérielle (médicaments : atorvastatine, metformine, aspirine cardio, lisinopril). La patiente a eu un infarctus du myocarde et un AVC frontal, et souffre de diarrhées intermittentes. L'examen clinique montre une cicatrice dans la zone de la fosse iliaque, un abdomen tendu avec peu de tension défensive ; une palpation sensible diffuse et pas de bruits intestinaux. Laboratoire : Hb & Tc norme, Crea 140, Leuco 13 G/l, pH 7,21, lactate 4 mmol/l. Quel est votre diagnostic provisoire ?

- a) Appendicite aiguë avec péritonite
- b) premier ulcère gastrique perforé
- c) l'ischémie mésentérique
- d) Iléus sur bride
- e) Gastroentérite

10. Un patient de 57 ans se présente aux urgences avec un abdomen ballonné, vomissements et nausées. Le patient a également subi une opération d'anastomose il y a 4 jours et est sous traitement opiacés. Examen clinique : bruits intestinaux, pas de péristaltisme, abdomen tendu. Que faire ? (Kprim)

- a) Traitement des nausées par des médicaments
- b) Contrôle des électrolytes sanguins
- c) Placer une sonde naso-gastrique
- d) Reprise chirurgicale

11. 92 ans, résidant à domicile, atteint de diabète sucré de type 2 depuis 50 ans. Prend de l'insuline longue durée (38U) le soir et de la metformine 850mg deux fois par jour. Pas de néphropathie et pas de neuropathie. L'HbA1c se situe régulièrement entre 7 et 7,5 %. Détérioration cognitive depuis un certain temps. Depuis 6 mois, il a moins d'appétit et perdu du poids. L'infirmière signale au médecin qu'il a récemment eu des lectures de glycémie inférieures à 4 mmol/l le matin. Quel est l'ajustement thérapeutique à effectuer ?

- a) Réduire la dose d'insuline
- b) Conversion de la metformine en sulfonylurée
- c) Répartir la dose d'insuline entre l'injection du matin et celle du soir
- d) Interrompre complètement la thérapie glycémique
- e) Traiter uniquement par voie orale

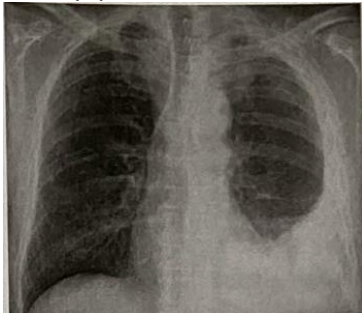
12. Femme de 42 ans accompagnée de son mari dans le service psychiatrique. Elle était devenue de plus en plus renfermée. Elle a peur d'être seule dans les lieux publics et de s'évanouir. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Agoraphobie
- b) Les troubles de panique
- c) La schizophrénie
- d) Trouble d'anxiété généralisée
- e) La claustrophobie

13. Une patiente de 76 ans se présente chez son médecin de famille en raison d'une forte douleur dans la cavité buccale. Depuis deux jours, elle présente des lésions extrêmement rouges, parfois hémorragiques. Ses antécédents médicaux comprennent de l'arthrite rhumatoïde, de l'hypertension artérielle et des maladies coronariennes. La patiente apporte avec elle une liste de ses médicaments. Parmi les médicaments suivants, lequel est le plus susceptible de provoquer ses symptômes ?

- a) Acide acétylsalicylique
- b) l'atorvastatine
- c) Lisinopril
- d) le méthotrexate
- e) le métoprolol

14. Un homme de 63 ans se présente aux urgences avec une douleur à la paroi thoracique droite et une dyspnée.



- a) Adéno-Ca pulmonaire
- b) Mésothéliome pleural
- c) Ca à Petites cellules du poumon
- d) Sarcoïdose
- e) Thymome

15. un enfant de 9 mois est emmené par ses parents en urgence à l'hôpital parce qu'il est fiévreux depuis le matin et qu'il crie. Au cours de l'examen, ils ont trouvé une fontanelle bombée et soupçonnent donc une augmentation de la pression intracrânienne et font évaluer le fond de l'œil par un ophtalmologue. L'ophtalmologue trouve une papille normale, mais des hémorragies rétiniennes en flammèches. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Toxoplasmose
- b) la méningite bactérienne
- c) Hydrocephalus malabsorptives
- d) Traumatisme dû aux secousses
- e) Rétinoblastome

16. Une femme enceinte se présente à son cabinet médical. Elle est préoccupée par la mort subite du nourrisson et souhaite que vous lui fournissiez davantage d'informations. Quels sont les facteurs de risque de la mort subite du nourrisson ? Que faut-il éviter en l'état actuel des connaissances ? (Kprim)

- a) Dormir dans le lit des parents
- b) Tétine pendant le sommeil
- c) Température dans la chambre à coucher $>21^{\circ}\text{C}$
- d) Dormir sur le dos

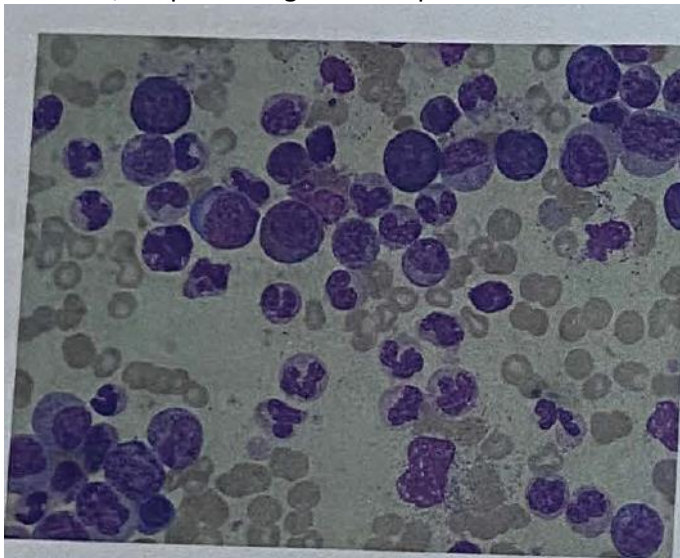
17. Une patiente de 21 ans se plaint d'un écoulement légèrement nauséabond de couleur verdâtre. Comment confirmer le diagnostic ?

- a) Frottis de sécrétion sur lame de microscope + 1-2 gouttes d'hydroxyde de potassium à 10%.
- b) Prélèvement de sécrétion sur lame de microscope + 1-2 gouttes de NaCl
- c) Fixation sur lames avec frottis cytologique
- d) frottis et séchage à l'air, puis microscope

18. Un homme de 75 ans porteur d'une prothèse auditive a un mal d'oreille sourd à droite, avec un gonflement, une rougeur et quelques vésicules visibles. Pas de douleur au tragus, pas de fièvre. Antécédents d'allergie à la pénicilline. Comment traiter ?

- a) Aciclovir
- b) Amoxicilline
- c) les céphalosporines
- d) les fluoroquinolones
- e) Prednisone

19. Quelle est la mutation responsable de la maladie du patient ? Laquelle des sélections suivantes confirme/adapte le diagnostic suspecté ?



- a) BCR-ABL
- b) EGFR
- c) HER2
- d) KRAS
- e) Mutation de la prothrombine

20. Un garçon de 7 ans est emmené chez le médecin de famille pour un problème de peau. Pendant des semaines, il n'a pas pu dormir la nuit à cause des démangeaisons, son appétit a également un peu diminué. L'examen révèle des zones érythémateuses, parfois excoriées, ressemblant à des macules dans les plis des extrémités. Quel examen peut confirmer le diagnostic suspecté ?

- a) Patch test
- b) Sérum IgG
- c) Dermatoscopie (loupe)
- d) la biopsie de la peau
- e) Investigation clinique

ELL

21. Patient âgé avec différents médicaments qu'il prend depuis longtemps. Dernièrement, il a eu des crampes aux mollets. Quel médicament pourrait en être responsable ?

- a) les bêta-bloquants
- b) diurétique de l'anse → Hypokaliémie, Hypomagnésémie → Crampes
- c) antiplaquettaires
- d) anti-calciques
- e) les comprimés homéopathiques

22. Femme d'âge moyen avec un ganglion thyroïdien palpable, sans enrouement, sans sensation de corps étranger, sans symptômes d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. Quelle est la procédure diagnostique suivante ?

- a) Scinti
- b) US
- c) Thyroïdectomie Totale
- d) MRI
- e) la biopsie true-cut

23. Une mère se rend chez le pédiatre avec son fils de 10 ans. Elle rapporte que le garçon a été à l'hôpital... Il mange moins et a perdu du poids. Il a aussi un comportement de méfiance. Avec le poids, l'enfant se situe au 10e percentile. Le pédiatre ne connaît pas l'ancien poids de l'enfant. L'examen physique et le laboratoire sont sans particularités. Le garçon ne présente aucun autre symptôme. Quelle est la procédure à suivre ?

- a) Rassurer la mère sur le fait que des troubles alimentaires peuvent survenir à cet âge
- b) Informer la mère et le fils des conséquences des troubles alimentaires et organiser un contrôle dans les 6 semaines
- c) Demandez à la mère de tenir un journal alimentaire pendant la semaine suivante et prévoyez un contrôle dans une semaine
- d) Admettre l'enfant dans une clinique psychiatrique pour enfants en vue d'une thérapie
- e) Orienter l'enfant vers un spécialiste de la psychiatrie infantile en urgence

24. Un surfeur de 55 ans se présente en raison d'un changement dans son œil droit. Jusqu'à présent, il n'avait pas besoin de lunettes ou de lentilles de contact. En conduisant une voiture, il a remarqué qu'il ne pouvait plus lire correctement les panneaux de signalisation de l'œil droit. Lors de l'inspection, l'image suivante apparaît. Qu'est est le diagnostic le plus probable ?

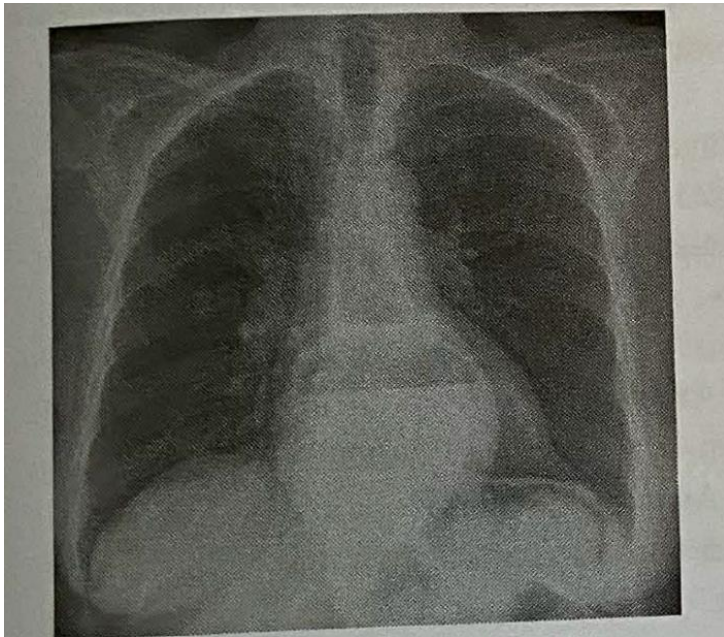


- a) la kératite
- b) la pinguecula
- c) Conjonctivite
- d) Ptérygion
- e) le carcinome épidermoïde

25. Patient présentant un exanthème papulomaculaire, une rhinite et de la fièvre - suspicion de rougeole. Ce qui s'applique à l'obligation de déclaration au médecin cantonal:

- a) Aucune obligation de déclaration.
- b) Notification du médecin en cas de suspicion dans les 2h.
- c) Notification du médecin en cas de suspicion dans les 24 heures.
- d) Notification du médecin en cas d'IgM positif dans un délai d'une semaine.
- e) Rapport de laboratoire en cas d'IgM-Ac positif dans les 2 heures.

26. Une patiente obèse de 66 ans se plaint d'un sentiment de plénitude et d'oppression thoracique croissante après avoir mangé depuis un à deux ans. En outre, ses performances physiques sont limitées. La patiente est envoyée par son médecin de famille avec la radiographie pulmonaire suivante :



Quelle est la thérapie de choix ici ?

- a) Chirurgie
- b) Perforation
- c) les antibiotiques
- d) Les bêta-bloquants
- e) les anticoagulants

27. Un homme âgé de 30 à 45 ans se présente dans son cabinet de médecine familiale. Son frère est mort subitement il y a deux ans. Aujourd'hui, le patient constate à plusieurs reprises des étourdissements pendant le sport et l'effort. Lors de l'examen clinique, vous remarquez une souffle systolique crescendo decrescendo au-dessus du centre du cœur. Pas de diastolique, mais la systolique est plus prononcée lors de l'auscultation.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Coarctatio aortae
- b) Valve aortique bicuspide
- c) Insuffisance de la valve mitrale
- d) Sténose pulmonaire
- e) Cardiomyopathie obstructive hypertrophique

28. Une jeune femme se présente avec une douleur abdominale basse gauche qui est présente depuis 6 heures. Elle rapporte également une traction abdominale qu'elle a ressentie depuis le rapport sexuel de la veille. Lors de l'examen gynécologique, un écoulement vaginal non sanglant et une douleur à la mobilisation du col. L'échographie abdominale montre une excavation visuellement vide dans la zone de l'annexe gauche et peu de liquide libre dans l'espace de Douglas. Le patient est afébrile, le laboratoire montre des signes d'infection légèrement accrus et le bêta-HCG dans les urines est négatif. En tant que médecin traitant, quelles mesures prenez-vous ensuite ?

- a) Déterminer la présence de bêta HCG dans le sang
- b) Amoxicilline p.o.
- c) Doxycycline i. v.
- d) la laparoscopie exploratoire
- e) l'échographie vaginale

29. Une patiente de 15 ans a pris 20x de paracétamol à 1g + 1 litre de rosé il y a 7 heures avec une intention suicidaire. Est maintenant asymptomatique en cas d'urgence, bon EG, respiration normale, pas de problèmes d'estomac, etc. Que faites-vous ensuite ?

- a) Mesure du taux de paracétamol + contrôle des valeurs hépatiques
- b) charbon actif, niveaux de paracétamol et les valeurs hépatiques
- c) le lavage gastrique, le taux de paracétamol et le taux d'alcoolémie
- d) charbon actif, de lavage gastrique et taux de paracétamol et les valeurs du foie

30. Un patient de 40 ans sans maladie antérieure reçoit un produit de contraste radiologique contenant de l'iode. Quels sont les complications/effets secondaires possibles ? K-Prim

- a) Oedème de Quincke
- b) Bronchospasme
- c) Le choc anaphylactique
- d) Urticaire

31. Un patient de 30 ans est trouvé avec une crise tonico-clonique et admis dans un hôpital central. A son arrivée, il ne bouge plus, mais n'est pas réactif. Deux heures plus tard, il n'a toujours pas repris conscience. Un CT cérébral d'urgence est effectué pour éliminer une hémorragie cérébrale, à l'exception d'une légère atrophie, et d'un l'examen clinique normal. Une conversation téléphonique avec les parents révèle, outre une consommation excessive d'alcool aucun antécédent médical. À quoi devrait ressembler la suite de la procédure ?

- a) EEG d'urgence
- b) IRM d'urgence
- c) thérapie anticonvulsive à la phénytoïne
- d) Surveillance de nuit toutes les deux heures
- e) Inscription pour le neuro-consulte du lendemain

32. Un garçon de 14 ans déclare avoir des selles molles depuis un an et n'a pratiquement jamais remarqué de sang dans ses selles. Depuis peu, il a de la fièvre et deux aphtes dans la bouche. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) La maladie de Crohn
- b) la colite ulcéreuse
- c) Giardia lamblia
- d) infection chronique par les salmonelles
- e) Oxyurie

33. Une patiente de 27 ans veut se faire poser un stérilet pour la contraception. Sur quoi doit-on l'informer ?

- a) un stérilet peut affecter la fertilité ultérieure
- b) Les stérilets ne sont pas adaptés à la contraception chez les personnes nullipares
- c) il faut s'attendre à un triple risque permanent d'infections abdominales par rapport aux autres méthodes contraceptives
- d) Le taux de contraception est de 90%.
- e) après 1 à 2 mois, un contrôle de la situation doit être effectué en raison du faible risque d'expulsion

34. Une femme de 50 ans, auparavant en bonne santé, vient vous voir pour un défaut du champ visuel. Un décollement de la rétine et un processus brun sous-rétinien sont détectés. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Hémorragie sous-rétinienne
- b) le mélanome uvéal
- c) Métastase d'un carcinome du sein
- d) Rétinoblastome
- e) Glaucome

35. Une femme de 30 ans se présente à l'urgence pour cause d'anxiété avec des sueurs, des tremblements, des nausées, des insomnies, des problèmes de concentration. Elle prend de la paroxétine 20mg depuis 4 jours, qui lui a été prescrit par son médecin de famille en raison d'une dépression de longue durée. Diagnostic ?

- a) l'acathisie
- b) Hypotension aiguë
- c) Transition vers la manie
- d) Syndrome sérotoninergique
- e) Dystonie aiguë

36. Chez un patient, un carcinome papillaire de la thyroïde de 5 cm de large est diagnostiqué par biopsie. Quelle est la prochaine étape ?

- a) Radioiodablation
- b) déterminer TSH, T3, T4
- c) Thyroïdectomie totale avec lymphadénectomie locale
- d) la scintigraphie de la thyroïde
- e) Hémi-thyroïdectomie

37. Une patiente de 48 ans atteinte d'une polykystose rénale connue chez l'adulte se présente avec un nouveau mal de tête sévère. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Crise de migraine
- b) Céphalée de groupe
- c) rupture d'anévrisme
- d) tumeur de la fosse postérieure
- e) glaucome

38. Une patiente de 80 ans souffrant de diabète sucré de type II et d'hypertension artérielle est traitée avec de la metformine et un IEC. Comme elle avait une diarrhée aqueuse et des crampes abdominales, son fils lui a donné des AINS. Quelques jours plus tard, le fils a remarqué une accélération de la respiration et une confusion chez la patiente, et les crampes abdominales se sont aggravées. Quelle est la cause probable des plaintes ?

- a) Effets des AINS sur les médicaments
- b) Gastro-entérite
- c) l'hyperglycémie
- d) Crise hypertensive
- e) l'acidocétose

→ Acidose lactique

lactique

39. Un patient souffre d'une fracture fermée du tibia lors de la pratique d'un sport. Au fil du temps, un syndrome de compartiment se développe. Dans quel ordre les symptômes attendus apparaissent-ils ?

- a) Trouble de la sensibilité > ; douleur > ; perte de force > ; absence de pouls
- b) Troubles de la sensibilité > ; absence de pouls > ; douleur > ; perte de force
- c) Douleur > ; absence de pouls > ; troubles sensoriels > ; perte de force
- d) Douleur > ; trouble de la sensibilité > ; perte de force > ; absence de pouls
- e) Douleur > ; troubles sensoriels > ; absence de pouls > ; perte de force

40. Agriculteur de 63 ans atteint d'un cancer pulmonaire NSCLC métastatique, a bénéficié deux fois de chimiothérapie sans effet sur la masse tumorale. Présentation aux urgences avec douleurs lombaires soudaines irradiant dans la jambe droite. Lâchages répétés de la jambe affectées par la perte de force. Douleurs lombaires, absence de réflexe du tendon patellaire, hypoesthésie périnéale, rétention urinaire aiguë.

- a) Polyneuropathie
- b) Le syndrome de Cauda equina
- c) SLA
- d) Myopathie paranéoplasique
- e) Polyradiculite (syndrome de Guillain Barre)

41. Une patiente de 43 ans arrive avec un nodule dans la poitrine qu'elle redécouvre lors d'une palpation. Quelle autre précision diagnostique est indiquée ci-après ?

- a) IRM du sein
- b) Mammographie et échographie
- c) CT thorax et abdomen
- d) la scintigraphie des ganglions lymphatiques sentinelles
- e) Biopsie et examen histologique

42. Une femme de 28 ans, à la 8e semaine de grossesse, présente une dyspnée aiguë et des douleurs au mollet gauche. L'examen échographique de la jambe gauche ne révèle aucun résultat. Quelle est la prochaine précision de diagnostic indiquée ?

- a) Radiographie du thorax
- b) la scintigraphie pulmonaire
- c) angio-IRM du thorax avec produit de contraste
- d) CT thorax/abdomen/pelvis avec PC
- e) CT thorax/abdomen/pelvis sans PC

43. Un homme de 34 ans vient au cabinet parce qu'il a remarqué une rougeur du gland, une légère dysurie et un écoulement purulent. Sous le microscope, la décharge montre des diplocoques et des leucocytes à la coloration au bleu de méthylène. Que devez-vous dire au patient ? (K-prim)

- a) le partenaire sexuel doit également être traité
- b) si elle n'est pas traitée, son état peut conduire à la stérilité
- c) il y a un effet similaire après la maladie qu'après la vaccination
- d) un préservatif peut protéger contre l'infection

44. Un alcoolique de 67 ans est allé voir le médecin de famille la veille en raison d'une douleur sur le bord de l'anus. Le patient se présente maintenant aux urgences avec un pouls de 135/min et une tension artérielle de 89/40. Localement, il y a une rougeur de l'anus au périnée. Lors de la palpation, une crépitation est ressentie. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Fissure anale aiguë
- b) Maladie de Crohn avec atteinte anale
- c) le prolapsus anal
- d) Gangrène gazeuse
- e) Hémorroïdes internes

45. Une patiente de 70 ans se présente avec un genou douloureux après une longue marche la veille. Cliniquement, elle a remarqué un genou douloureux et chaud, après quoi ils décident de faire une ponction articulaire. Les cristaux de pyrophosphate de calcium sont visibles dans le liquide de ponction. De quoi souffre le patient ?

- a) Goutte
- b) Pseudo-goutte
- c) L'arthrite septique
- d) L'arthrite réactive
- e) Arthrose activée

46. Une jeune patiente signale des habitudes alimentaires restrictives. Trois fois par semaine, elle n'arrive pas à se retenir et mange trop. Afin de ne pas prendre de poids, elle vomit. Quelle est la première conséquence à attendre de son comportement ?

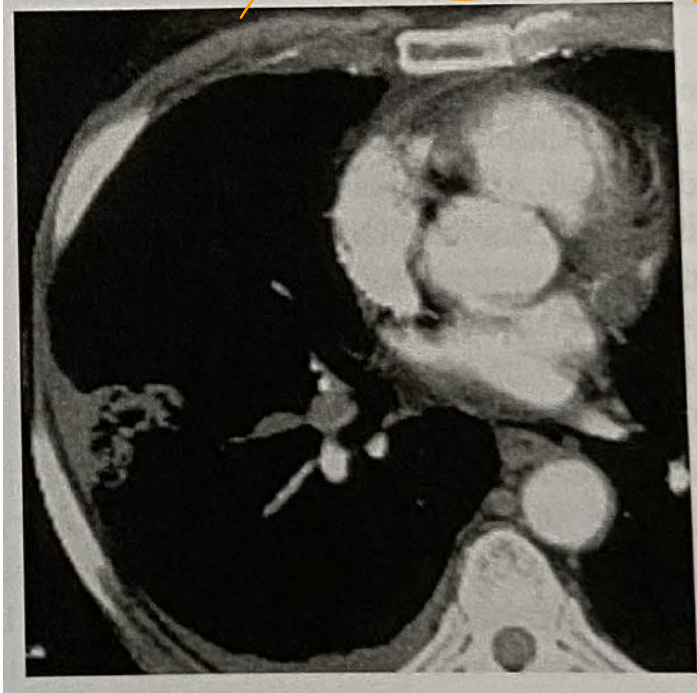
- a) L'ostéoporose
- b) Détérioration des dents
- c) l'infertilité
- d) Arythmie cardiaque
- e) l'anémie mégaloblastique

47. Chez le médecin de famille : Femme, 64 ans, depuis 4j douleurs sous le sein droit irradiant dans le dos. Ne dépendant pas du mouvement ou de la respiration, sans douleurs à la palpation du dos ou des vertèbres, la radiographie du thorax est peu significative. Troponine et D-dimère non significatifs. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Crise cardiaque
- b) LE
- c) Musculo-squelettique
- d) Herpès zoster
- e) Pleurite

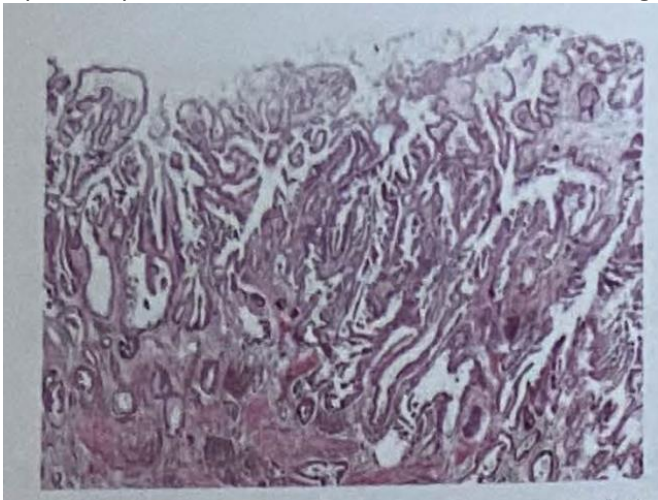
EP

48. femme de 68 ans se présente avec de nouvelles douleurs thoraciques dépendantes de la respiration. Dans son histoire, on connaît un carcinome mammaire localisé, qui a été excisé et traité au tamoxifène il y a 8 ans, elle est revenue d'un voyage en Thaïlande il y a 2 jours et a depuis lors une toux supplémentaire avec des crachats sanguinolents et une légère dyspnée à l'effort. Statut : TA 128/78 mmHg, FC 89/min, FR 16/min, Temp. 37,3°. Un angio-CT montre l'image suivante : Quelle est la cause la plus probable de l'opacité ?



- a) Infarctus du myocarde
- b) Infarctus pulmonaire
- c) Pneumonie
- d) L'épanchement pleural
- e) Tamponnade péricardique

49. Patiente de 76 ans. Au cours d'une coloscopie, le résultat est rendu et se caractérise par un adénome qui ne peut être enlevé par voie endoscopique. Une résection sigmoïde partielle par laparoscopie est effectuée. Lors de l'examen histologique ultérieur, on trouve :



Ce qui est décisif pour le pronostic:

- a) le degré de dysplasie
- b) Mutation de KRAS
- c) la taille du polype
- d) Infiltration dans les tissus environnants
- e) le degré d'inflammation des tissus environnants

EP → Infarctus pulmonaire

→ = SERM → risque MTEV

50. Le patient se présente avec un gonflement de la paupière inférieure du côté gauche, localisé au milieu. Le gonflement fait mal au toucher. Vision 10/10. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Carcinome basocellulaire
- b) Chalazion
- c) Hordeolum
- d) la dacryocystite
- e) Dacryoadénite

51. Il y a deux jours, un cuisinier se fait une coupure de 6 cm de long sur son avant-bras, qu'il a traité lui-même. Maintenant, il consulte aux urgences. La blessure est douloureuse, rouge, purulente. Pas de fièvre, bon EG. Quel est le traitement adéquat ?

- a) Antalgie, suture
- b) Suture, antibiotiques p.o.
- c) Pansement, antibiotiques locaux
- d) pansements, antibiotiques p.o.
- e) Débridement des plaies, traitement par fermeture secondaire

52. Une femme de 70 ans est parfois constipée. Elle prend donc des laxatifs. Parfois, elle n'a pas pu déféquer pendant 9 jours. Mais elle a aussi de la graisse dans les selles. Lors de l'examen clinique, on constate une diminution du tonus sphinctérien et, lors de la pression, une protubérance circulaire de la muqueuse. Qu'est-ce qui explique le trouble intestinal ?

- a) Entérocèle
- b) Prolapsus rectal
- c) Hémorroïdes Grade m
- d) le prolapsus anal

53. Une physiothérapeute de 36 ans se rend au cabinet de son médecin de famille pour obtenir des conseils sur l'ostéoporose. Sa mère souffre d'une grave ostéoporose. La jeune femme fait beaucoup de sport (deux fois par semaine de la musculation et du jogging, des claquettes, parfois du tennis et de la natation) et aimerait obtenir des informations sur ces sports et leurs bienfaits. Quel sport est le moins adapté pour réduire le risque d'ostéoporose ?

- a) Les claquettes
 - b) l'entraînement musculaire
 - c) le jogging
 - d) le tennis
 - e) Natation → Pas d'impact sur la densité osseuse
- stimule la formation osseuse*

54. Une patiente de 78 ans en bon EG se présente avec des douleurs de la colonne thoracique depuis 2 jours. Le status montre une douleur de pression et de cliquetis au-dessus du Th7. Pas de douleur de compression et conditions locales discrètes.

- a) Hernie discale
- b) névralgie intercostale
- c) fracture ostéoporotique de la colonne vertébrale
- d) sténose du canal rachidien

55. Un enfant de 4 mois avec une première crise tonico-clonique du côté gauche apparaît. Une grossesse et un accouchement normaux.

Pas de fracture au niveau de la boîte crânienne. Hématome sous-dural droit au scanner. En funduscopie, hémorragies rétinienne en flammèches. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) maltraitance
- b) Rétinopathie héréditaire
- c) hémorragie spontanée dans l'hémophilie
- d) saignement sur malformation artério-veineuse

56. Un homme de 35 ans se présente à son cabinet avec des lésions bleu-violet non prurigineuses sur plusieurs parties du corps ainsi que sur les muqueuses. Jusqu'à présent, il a été en bonne santé. Que faire ?

- a) la clarification atopique
- b) Antécédents médicaux
- c) l'historique des voyages
- d) Histoire sexuelle

57. Une femme de 50 ans atteinte de sclérose en plaques est amenée aux urgences accompagnée de son mari. Hémiparésie à gauche. La TCC montre un infarctus médial de A. cerebri sur la droite. La patiente est actuellement sous thérapie IFN- β ; selon son mari, elle a une fièvre intermittente depuis plusieurs semaines. L'examen montre un souffle systolique nouvellement apparu maximal au-dessus du 5e EIC médioclaviculaire gauche, paramètres de rétention rénale accrus. Cause ?

- a) Endocardite
- b) ESI de la β -thérapie de l'IFN
- c) Poussée des SEP
- d) la méningite

58. Homme souffrant d'une insuffisance rénale aiguë, dans quelle situation l'indication d'hémodialyse est-elle indiquée ?

- a) un taux de sodium sérique de 130 mmol/l
- b) un phosphate sérique de 2,3 mmol/l (valeur standard : 0,85 - 1,8 mmol/L)
- c) complexe QRS élargi $> 0,11$ s dans l'ECG
- d) un pH sanguin de 7,25

Parmi les options données, la situation qui indique une hémodialyse chez un homme souffrant d'une insuffisance rénale aiguë est : c) complexe QRS élargi $> 0,11$ s dans l'ECG
Cela suggère une hyperkaliémie sévère, qui est une indication urgente pour l'hémodialyse. Voici un résumé des indications pour l'hémodialyse dans les cas d'insuffisance rénale aiguë :
Indications pour l'hémodialyse
Acidose métabolique sévère : par exemple, pH $< 7,1$ et/ou bicarbonate sérique < 12 mmol/L
Anomalies électrolytiques sévères réfractaires : par exemple, urgence hyperkaliémique, crise hypercalcémique
Symptômes d'urémie : par exemple, encéphalopathie urémique, encéphalopathie urémique et/ou saignement
Surcharge liquidienne réfractaire à la gestion médicale : par exemple, dans l'insuffisance rénale chronique (CKD), l'insuffisance cardiaque congestive (CHF)
Intoxication ou surdosage avec une substance dialysable : par exemple, lithium, alcools toxiques
Indications urgentes pour l'hémodialyse : "A.E.I.O.U."
Acidosis (acidose)
Electrolyte abnormalities (anomalies électrolytiques, par exemple, hyperkaliémie)
Ingestion (intoxications)
Overload (surcharge liquidienne)
Toxicity (toxicité) (intoxications)
Uremic symptoms (symptômes d'urémie)

59. Un homme de 30 ans se présente aux urgences avec une gastro-entérite. Son ami est également atteint d'une gastro-entérite.

Signes vitaux TA 105/55, fréquence cardiaque 130/min, T 38,2°C,

Laboratoire : paramètre de rétention rénale augmenté, Numération plaquettaire normale.

Urine/stix : nitrite, protéines, glucose, bilirubine, urobilinogène, érythrocytes, leucocytes (-), corps cétoniques (+)

Quelle est la cause la plus probable de l'insuffisance rénale ?

- a) la glomérulonéphrite
- b) Carcinome rénal
- c) des calculs dans les voies urinaires des deux côtés
- d) le syndrome hémolytique et hématologique
- e) l'insuffisance rénale prérénale

60. Une jeune fille de 13 ans vous consulte pour la première fois. Elle se situe dans le 3ème percentile en ce qui concerne le poids et la taille. Pas encore de ménarche. Sinon, elle passe inaperçue. Début des poils pubères et début du développement des seins des deux côtés. Le père a une taille du 75e centile, la mère du 50e, Qu'est ce qui explique probablement le retard de croissance ?

- a) Anorexie
- b) Le syndrome de Turner (XO)
- c) le retard de croissance constitutionnelle
- d) Achondroplasie

61. Quel médicament ne doit pas être administré à une femme enceinte ?

- a) Inhibiteurs de l'ECA
- b) Bêta-bloqueur
- c) Ca-antagonistes
- d) le paracétamol

62. Une patiente de 67 ans est venue vous voir à cause d'une perte soudaine de la vue il y a deux jours, survenue alors qu'elle jouait avec ses petits-enfants. Le patient fait également état d'une fatigue croissante. Elle se plaint de pouvoir faire plus de courses à cause de douleurs aux deux épaules. La patiente a souffert de migraines dans le passé, mais récemment elle a de nouveau eu des maux de tête. Le statut est sans défraiement, sauf des douleurs à la ceinture scapulaire. En outre, la palpation de l'artère temporale indurée.

Quelle est la mesure la plus importante à l'heure actuelle ?

- a) IRM cérébrale
- b) Stéroïdes systémiques
- c) Consultation médicale des yeux
- d) Les biopsies des artères temporales
- e) Thérapie physique

63. Un patient de 78 ans, interrogé dans son enfance pour des raisons inconnues, a perdu un œil. Il vient maintenant dans votre cabinet en raison de difficultés de lecture qui auraient commencé il y a quelques mois. Il rapporte qu'il voit les lettres floues. De quoi souffre le patient ?

- a) Cataracte
- b) Détachement de la rétine
- c) Occlusion de la veine rétinienne
- d) Hémianopsie gauche homonyme
- e) Dégénérescence maculaire

64. Un enfant de 6 ans doit être réanimé après avoir reçu un coup à la poitrine (balle de foot). Quelle en est la cause ?

- a) Fibrillation ventriculaire
- b) Torsade de Point
- c) Fibrillation auriculaire
- d) la tachycardie supraventriculaire

65. Un homme de 30 ans coince son doigt dans une porte. La phalange distale est maintenant gonflée, rouge et un volumineux hématome s'est formé sous l'ongle. Quelle est la thérapie de choix ?

- a) Calmer la phalange terminale dans une attelle en plâtre
- b) La trépanation pour soulager l'hématome
- c) Enlever l'ongle, l'hématome et le pansement
- d) Enlever l'ongle et le pansement
- e) attendre que l'hématome soit résorbé

66. Vous êtes consulté par un patient de 64 ans qui souffre de toux et de dyspnée progressive depuis 6 semaines. Il rapporte des crachats jaunâtres, parfois avec un mélange sanglant. Il nie la fièvre. Le patient est un fumeur (60 UPA) et a perdu 3 kg de poids au cours des 4 dernières semaines. Dans l'état, vous pouvez trouver un bruit de respiration réduit sur le côté gauche. De quelle maladie le patient souffre-t-il ?

- a) Bronchiectasie
- b) le carcinome bronchique
- c) Pneumothorax spontané
- d) Pneumopathie interstitielle
- e) Pneumonie à pneumocoques

67. Un garçon de 14 ans ne voit plus très bien de l'œil droit. En raison des symptômes, une thérapie avec humidification et gouttes oculaires de ciprofloxacine a été lancée il y a deux jours. L'état de santé ne s'est pas amélioré en dessous. Acuité actuel avec correction : 0,3 à droite et 1,0 à gauche. Le fond de l'œil semble normal. En colorant avec de la fluorescéine, on peut voir l'image ci-dessous. Comment la thérapie doit-elle se dérouler ?



- a) Poursuivre la thérapie
- b) Glucocorticoïdes locaux
- c) Aciclovir local
- d) Cefaclor local
- e) faire un frottis de la cornée

68. Une femme au foyer de 66 ans se rend chez le médecin de famille en raison d'une blessure ouverte sur la face interne de la cheville gauche, d'une valeur d'environ 5 francs. La douleur croissante l'affecte. Elle prend un comprimé contre l'hypertension artérielle, n'a pas de fièvre et est en bonne condition. L'examen clinique montre une varicose clairement prononcée sur la jambe gauche, des changements de pigmentation et des îlots cutanés blanchâtres évoquant une atrophie blanche. Qu'est-ce que le diagnostic complémentaire :

- a) Index cheville-bras (ABI)
- b) US duplex
- c) la biopsie
- d) Angiographie
- e) Phlébographie

69. Une femme de 32 ans, Gravida 3 Para 0, 10 semaines après une FIV, est tombée il y a 11 jours sur sa bicyclette. Elle a ensuite été hospitalisée pendant deux jours, au cours desquels des examens approfondis ont été effectués. À l'exception d'abrasions sur le flanc droit, rien n'a pu être détecté et la patiente a été renvoyée chez elle dans un bon EG. Aujourd'hui, en montant dans la voiture, elle a eu des vertiges et s'est presque effondrée. Elle a ensuite été immédiatement emmenée aux urgences par son mari. Elle s'y présente effrayée, excitée et pâle. Elle a une tension artérielle de 110/78 mmHg, un pouls de 86/min, une fréquence respiratoire de 26/min et une saturation en oxygène de 92 %. Quelle est la prochaine étape de diagnostic ?

- a) IRM du corps entier
- b) Angio-CT thorax et abdomen
- c) IRM du thorax et de l'abdomen
- d) Échographie du thorax et de l'abdomen
- e) Scanner polyspiral du crâne, du thorax et du pelvis

70. Aux urgences, un patient de 80 ans souffrant de douleurs abdominales diffuses est présenté. L'abdomen est ballonné, aucun bruit intestinal n'est audible lors de l'auscultation. La douleur a commencé soudainement la veille au soir, après le repas. Le patient a des antécédents de coronaropathie et de fibrillation auriculaire. Quelle imagerie ouvre la voie à un diagnostic différentiel plus poussé ?

- a) ASP, 2 plans
- b) CT abdominal
- c) Echographie abdominale
- d) AngioCT abdomen
- e) IRM de l'abdomen

71. Un cadre de 50 ans se présente aux urgences avec des douleurs abdominales diffuses depuis une heure. Il a été en bonne santé jusqu'à présent, à l'exception de quelques maux de tête occasionnels. Statut : **péritonisme aux quatre quadrants**, absence de bruits intestinaux. Quelle est la prochaine étape? **Péritonisme = Urgence!**

- a) CT abdomen
- b) Gastroduodénoscopie
- c) perfusion de NaCl
- d) Échographie abdominale
- e) la laparoscopie diagnostique

Un cadre de 50 ans se présente aux urgences avec des **douleurs abdominales** diffuses depuis une heure, un **péritonisme** aux quatre quadrants et une **absence de bruits intestinaux**. Ces signes cliniques suggèrent une **urgence abdominale** grave nécessitant une évaluation rapide.

Analyse des Options :

- CT abdomen (a) : Un scanner abdominal est utile pour diagnostiquer diverses causes de douleur abdominale, mais il ne doit pas retarder une intervention chirurgicale si une urgence vitale est suspectée.
- Gastroduodénoscopie (b) : Cette procédure endoscopique permet d'examiner l'œsophage, l'estomac et le duodénum, mais elle n'est pas indiquée en première ligne dans un contexte de péritonisme aigu.
- Perfusion de NaCl (c) : Une perfusion peut être nécessaire pour stabiliser un patient, mais ce n'est pas la première étape pour diagnostiquer et traiter une cause chirurgicale aiguë.
- Échographie abdominale (d) : Bien que l'échographie puisse aider à identifier certaines pathologies abdominales, elle n'est pas suffisante pour exclure toutes les causes urgentes nécessitant une intervention.
- **Laparoscopie diagnostique (e)** : Cette procédure permet une visualisation directe de la cavité abdominale et peut être convertie en intervention thérapeutique immédiate si une pathologie chirurgicale est identifiée.

Conclusion

La laparoscopie diagnostique (e) est la meilleure option car elle permet une évaluation directe et rapide de la cavité abdominale, ce qui est crucial dans le cas d'un péritonisme aigu avec suspicion de pathologie nécessitant une intervention chirurgicale immédiate.

72. Une patiente se présente chez le médecin de famille avec une fatigue et une apathie accrues. Elle a pris du poids, est souvent constipée et intolérante au froid. Elle a également une perte de cheveux nouvelle avec des cheveux cassants. Statut : hyporéflexie. Laboratoire : TSH élevée et T4/ T3 faibles, CK fortement augmentés. Quel est le médicament en cause ?

- a) Amiodarone
- b) l'atorvastatine
- c) Métoprolol
- d) l'amlodipine
- e) Ramipril

73. Patient présentant une stéatorrhée et du sang dans les selles. Vous palpez à 6 cm de l'anus une masse tumorale. La coloscopie avec biopsie confirme la présence d'un adénocarcinome. Quels sont les examens complémentaires nécessaires ? [K-Prim]

- + a) IRM du bassin
 - + b) Détermination de la CEA
 - + c) CT thorax/ abdomen
 - d) Gastrographie
 - + e) Rectoscopie rigide
- Distance à la marge anale*
- Coloscopie complète ✓
 - Biopsie ✓
 - CEA
 - CT thoraco-abdominale → M
 - IRM du pelvis → T, N
 - Etude de la CRM → IRM pour la stadification
 - Marge circonférentielle de résection CRM
 - Tumeur T3 du moyen rectum
 - Distance la plus courte entre la tumeur et le fascia du muscle rectum
 - CRM complémente si c T3/T4
 - Facteur principal de récidence local (>T)
 - 92.9% de détermination correcte en IRM
- 

74. Une patiente de 27 ans se présente à vous aux urgences. Elle se plaint de diarrhées, sans sang. Elle n'a pas de douleurs et est afebrile. Il y a trois mois, elle était en vacances à Bali. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) M. Crohn
- b) La maladie coeliaque
- c) Colon irritable
- d) Giardiase
- e) Amibiase

75. Enfant de 2 mois avec une adaptation postnatale sans faille. A pris seulement 500g de poids. Bon appétit et bonne quantité de boisson. Depuis quelques jours, légère toux. Quelles sont les autres étapes utiles ? (k Prim)

- a) Anticorps anti-Transglutaminase
- b) Recommandation pour la conversion au lait de soja
- c) Test à la sueur
- d) Rx thoracique pour l'évaluation du médiastin

76. Une patiente de 27 ans se présente avec un mal de gorge et des douleurs de déglutition. Au status, on remarque un mauvais état dentaire et une mauvaise haleine. Lors de l'inspection, vous voyez l'image suivante :



Quelle est la prochaine étape ?

- a) Antibiothérapie i. v.
- b) L'antibiothérapie p.o.
- c) la biopsie
- d) frottis
- e) le test rapide de dépistage des streptocoques

77. Patiente atteinte d'un carcinome du sein. Quel examen immunohistochimique n'est pas pertinent pour la suite de la procédure ?

- a) Récepteurs de progestérone
- b) Récepteurs d'œstrogènes
- c) Indice de prolifération
- d) Statut Her2
- e) Cadherin 17

78. Un patient de 75 ans va recevoir un prothèse totale de la hanche en raison d'une douleur intense avec une arthrose de la hanche connue. Il présente également une sténose sévère de la valve aortique en ayant déjà syncopé. Quelle est la suite de la procédure ?

- a) Effectuer une opération de la hanche sans plus attendre
- b) Premier remplacement de la valve aortique, plus tard au cours d'une seconde chirurgie, prothèse de la hanche
- c) une chirurgie, qui consiste à remplacer dans un premier temps la valve aortique puis l'articulation de la hanche
- d) Une chirurgie, d'abord de la hanche, puis de la valve aortique
- e) Remplacement de la valve aortique uniquement

79. Une femme reçoit 2 concentrés d'érythrocytes en postopératoire. 5 minutes après le début de la transfusion, elle a de la fièvre, des frissons, des douleurs au dos et au flanc, et elle devient hypotendue (70/40). Quelle est la mesure la plus urgente ?

- a) Traitement antiallergique
- b) Arrêt de la transfusion
- c) Traitement antipyrétique
- d) Passage à la 2e transfusion
- e) Traitement avec des analgésiques

80. Après une parotidectomie, un homme a le coin gauche de la bouche qui s'affaisse. Quel nerf a été blessé lors de l'opération ?

- a) N. facialis
- b) N. trigeminal
- c) N. maxillaris
- d) N. mandibularis
- e) N. mentalis

81. Une patiente de 59 ans se présente avec des vertiges, une tachycardie et de l'agitation depuis plusieurs jours. Le seul médicament qu'elle prend est la L-thyroxine comme traitement de substitution, suite à une résection de la thyroïde il y a 12 ans. Elle mesure 172 cm, pèse 94 kg et sa tension artérielle est de 140/80 mmHg. Son ECG montre un rythme sinusal tachycardique avec une fréquence cardiaque de 112/min. Lors de l'ECG d'il y a un an, le rythme sinusal était encore normocarde.

Qu'allez-vous faire ensuite ?

- a) Anxiolytiques
- b) Déterminer les paramètres de la thyroïde (TSH, T3 & T4)
- c) Les bêta-bloquants
- d) Echocardiographie
- e) Massage du sinus carotidien

82. Une patiente de 15 ans vient vous voir à la polyclinique gynécologique et souhaitant avorter. Un test de grossesse confirme la grossesse, elle est dans la 10ème de SA. Il est important pour la patiente que ses parents ne l'apprennent pas. Que faites-vous ?

- a) Expliquer à la patiente que ses parents doivent être informés, car ils sont les représentants légaux.
- b) Dites à la patiente qu'en l'absence de raisons médicales, l'avortement est impossible.
- c) Demander la permission au comité d'éthique sans en informer les parents.
- d) Autoriser l'interruption de grossesse et orienter la patiente vers un point de contact pour les mineurs.

83. Un garçon de 6 ans se présente avec un scrotum tuméfié, homogène et indolore. Le gonflement est asymétrique, plus à droite qu'à gauche. Les constatations sont plus prononcées le soir, le matin souvent aucune constatation n'est visible. Les deux testicules sont situés dans le scrotum. La diaphonoscopia est positive.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Hernie directe
- b) la varicocèle
- c) spermatocele
- d) Hydrocele
- e) Tumeur testiculaire

84. Femme en choc anaphylactique. Quel est le traitement médicamenteux indiqué ?

- a) Adrénaline i.v. 1 mg, Tavegil i.v. 2 mg, Solumedrol i.v. 500mg
- b) adrénaline i.m. 500 mcg, Tavegil 2 mg, Solumedrol 500 mg
- c) Adrénaline s.c. 500 mcg, Tavegil i.v. 2 mg, Solumedrol i.v. 500 mg
- d) Tavegil 2 mg, Solumedrol 500 mg

85. Quelle prophylaxie antibiotique après une chirurgie dentaire en cas de régurgitation mitrale ?

- a) 1x ; avant l'intervention
- b) 2x ; avant et après la procédure
- c) aucune
- d) 1 x après l'opération

86. Un homme de 35 ans est amené aux urgences après une bagarre. Il est agressif, violent, menace les médecins et les infirmières. Le médecin de garde veut l'isoler en chambre de soins. Est-ce légal ?

- a) non, le patient ne peut pas donner son consentement
- b) non, aucun psychiatre n'a encore été appelé
- c) non, doit être ordonné par un juge de paix
- d) oui, car il s'agit probablement d'un problème chronique et le patient a besoin d'un traitement
- e) oui, parce qu'il présente un danger aigu pour autrui

87. Un corps non identifiable est retrouvé dans un appartement. Les voisins n'ont pas vu le locataire depuis deux semaines. Il a eu un infarctus sévère il y a cinq semaines, est atteint de tuberculose et bénéficie de l'Al. Que faire ?

- a) Informer le médecin cantonal
- b) Délivrer un certificat de décès et informer la police
- c) délivrer un certificat de décès au nom du défunt
- d) ne pas délivrer de certificat de décès car il semble s'agir d'un décès naturel
- e) Délivrer un certificat au nom du défunt, informer l'assurance

88. Un garçon de 15 ans et demi se présente à votre bureau pour une plainte de retard de croissance. Taille : 1,53 m. Entre 3 et 25 ans, il a toujours évolué entre le 3ème et le 25ème percentile de sa taille, avec un poids de 39 kg normal pour sa taille. Actuellement avec une taille inférieure au 3ème percentile (-2,5 SD). Aucun signe de puberté pour l'instant. Âge des os : 13 ans. Père 1,69 m de haut, a eu un pic de croissance à 16 ans, rasé à 18 ans. Mère 1,63 m, ménarche à 15 ans. Quel est le premier diagnostic probable ?

- a) Retard de croissance constitutionnelle avec retard
Début de la puberté
- b) Hypogonadisme hypogonadotrophique
- c) Hypogonadisme hypergonadotrophique
- d) Anomalie chromosomique
- e) la carence en hormone de croissance

89. Un garçon de 12 ans connu pour un diabète de type I est amené aux urgences par sa mère. Il est tombé à vélo il y a une heure et s'est cogné le visage, mais il n'a pas perdu connaissance. L'examen a révélé des abrasions sur ses mains et une large plaie contuse au menton. Il mentionne une douleur rétro-auriculaire des deux côtés.

Quelle est la prochaine étape de diagnostic ?

- a) HbA1c
- b) CT du crâne facial
- c) Prophylaxie du tétanos
- d) le soin et le contrôle des plaies
- e) EEG

90. Un homme de 25 ans se présente au cabinet du médecin généraliste avec des mois de respiration nasale altérée et des sécrétions blanches visqueuses provenant de son nez. En outre, il se plaint depuis un an d'une altération de l'olfaction de plus en plus fréquente. Au cours de l'examen, vous voyez une respiration nasale bilatérale entravée par des tissus blanchâtres et lisses des deux côtés. Que faut-il demander dans les antécédents médicaux ? (K prim)

- a) le reflux
- b) intolérance à l'aspirine ou aux AINS
- c) l'asthme bronchique
- d) Allergie
- e) Polyposis nasale

91. Une mère amène son fils de 2 ans à votre consultation . Elle signale que sa croissance est retardée par rapport à celle de ses deux sœurs aînées pour le même âge. De plus, il ne prend pratiquement pas de poids et n'a guère d'appétit. Son abdomen est souvent distendu et ses selles sont le plus souvent molles malgré l'apport de nourriture diminué. Elle avait allaité son fils jusqu'au 5e mois, et les problèmes digestifs ne sont apparus qu'après cela. Dans le tableau clinique, l'abdomen est ballonné, l'enfant est légèrement larmoyant et pâle, et il y a un retard de croissance objectivable.

Quelle serait la prochaine étape de diagnostic ?

- a) Sédiment urinaire
- b) Échographie abdominale
- c) Test de transpiration
- d) Détermination des anticorps de la transglutaminase
- e) l'analyse des selles pour détecter les parasites

92. Un garçon de 8 ans est amené aux urgences à 20 heures. Il s'est entraîné avec ses amis après l'école. Le soir, il dit à sa mère qu'il sentait son cœur battre très vite. Sa mère palpe un pouls très rapide chez le garçon. Au triage, le garçon rapporte qu'il a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Ils palpent un rythme cardiaque >220/ min. L'ECG montre une tachyarythmie régulière. Aucune autre anomalie. Quelle est la meilleure mesure thérapeutique ?

- a) Amiodarone IV.
- b) Adénosine IV.
- c) Électrocardioversion
- d) Inhalation de bêta sympathomimétiques
- e) la nifédipine

93. Un homme de 55 ans consulte aux urgences. Il est tombé en skiant et a maintenant mal à l'épaule. La rotation externe et l'abduction ne sont pas possibles. Une déformation n'est pas visible. Le mouvement passif est possible sans restrictions. Sur l'image radiographique prise, aucune fracture n'est visible. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Contusion de l'épaule
- b) Dislocation acromio-claviculaire
- c) Rupture du tendon du long biceps
- d) Luxation humérale postérieure
- e) Rupture complète de la coiffe des rotateurs

94. Une femme de 31 ans se plaint de douleurs aiguës dans le bas-ventre droit depuis la veille, à la suite de rapports sexuels. L'examen gynécologique montre une douleur perceptible au niveau du col de l'utérus et l'échographie montre peu de liquide libre dans le bassin et une structure kystique arrondie dans la région de l'ovaire droit. Quel est le diagnostic suspecté ?

- a) Maladie inflammatoire pelvienne
- b) Appendicite
- c) rupture d'un kyste ovarien
- d) la diverticulite
- e) Vaginite

95. Une alcoolique de 65 ans se plaint d'une paresthésie progressive et ascendante des deux pieds. De plus, elle aurait remarqué une paralysie faciale bilatérale. En outre, elle a remarqué des battements de cœur rapides, un cœur qui trébuche et une transpiration accrue. Il y a quelques semaines, elle a eu une diarrhée sévère causée par *Campylobacter jejuni*. Elle semble de plus en plus confuse. Le réflexe achilléen est diminué, le réflexe patellaire est maintenu. L'examen clinique montre une parésie M 4/5 du M. extensor hallucis longus.

Laboratoire : Auto-anticorps contre la myéline et les gangliosides + (GMI-3)

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) PNP diabétique
- b) PNP éthylique
- c) Le syndrome de Guillain-Barré
- d) Syndrome de compression radiculaire
- e) La sclérose en plaques

96. Un polytrauma arrive en salle de choc. Status : Glasgow 3, saignement du visage, sang dans la bouche, pas de murmure respiratoire à gauche. Quelle est la procédure à suivre ?

- a) Intubation, acide tranexamique, drainage thoracique, total body scan
- b) Drainage thoracique, acide tranexamique, intubation, scanner du corps entier
- c) CT de la tête, drainage thoracique, intubation
- d) Drainage thoracique, intubation, acide tranexamique, scanner du corps entier
- e) Aucune des séquences n'est correcte

97. Un retraité de 67 ans consulte car il présente depuis hier matin une dyspnée croissante. Il a une toux accrue, ce matin des crachats verdâtres. Il prend du Ramipril et de l'Atorvastatine et depuis un infarctus du myocarde il y a 4 ans, de l'Aspirine Cardio. Fumeur 50 UPA. IMC 28. état : TA 150/70, FC 90, T 37,6°C tympanique. Rales grossiers sur tous les champs pulmonaires. Battements de cœur purs et rythmés. Les jambes sont minces. Laboratoire : Hb 15g/dl, leucocytes 11 G/l, plaquettes 350 G/l CRP 45 mg/l, Na 136 mmol/l, K 4,5 mmol/l, Gluc 6,8 mmol/l pO₂ 62 mmHg (70-90 mmHg) pCO₂ 56 mmHg (35-45 mmHg), bicarbonate 27 mmol/l (23-27 mmol) Créatinine 104 µmol/l, D-dimères 0,6 mg/l, (< 0,5 mg/l), BNP 135 pg/ml (< 100 pg/ml)

Qu'est-ce qui est le plus probablement responsable de ses symptômes ?

- a) Insuffisance cardiaque aiguë
- b) Embolie pulmonaire
- c) une BPCO exacerbée
- d) réaction indésirable à un médicament
- e) Syndrome coronarien aigu

98. Qu'est-ce qui s'applique à la radiographie suivante ? (K-prim)



- a) espace articulaire étroit
- b) plateau tibial déplacé
- c) la rotule est trop haute
- d) il existe des signes indirects d'épanchement articulaire
- e) fracture rotulienne

99. Le patient se présente chez votre médecin de famille avec une douleur intense dans l'œil gauche. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- a) Dacryocystite
- b) Phlegmons
- c) l'acanthome kératosique
- d) Carcinome basocellulaire
- e) Chalazion

100. Un patient de 57 ans est traité en tant que patient hospitalisé pour une pneumonie. L'infirmière leur dit que l'état du patient s'aggrave à nouveau. Leucocytes : 12 G/1 CRP : 36 mg/1
Vous demandez une radiographie du thorax et voyez l'image suivante :



Quel est votre diagnostic ?

- a) Embolie pulmonaire
- b) Pneumothorax
- c) Récurrence de la pneumonie
- d) Insuffisance cardiaque gauche
- e) Tumeur du poumon

101. Un patient de 70 ans a subi une brève perte de conscience pour la première fois alors qu'il était allongé dans son lit. Sa femme a rapporté que son visage était devenu un peu bleu et que de courtes secousses tonico-cloniques étaient visibles sur ses bras. Il a repris conscience spontanément et n'a pas été confus par la suite. De même, aucune morsure latérale de la langue ou perte d'urine n'a été constatée. Le patient est connu pour une hypertension artérielle, un diabète sucré de type 2 et une insuffisance cardiaque gauche chronique avec une FEVG de 25 %. Quelle est la cause de la perte de conscience ?

- a) Orthostatique
- b) vasovagale
- c) Cardiaque
- d) Epileptique
- e) Psychogène

102. Patient de 45 ans atteint de diabète sucré de type 2 et présentant une tuméfaction et des douleurs progressives au niveau du scrotum. La CRP et les leucocytes ont augmenté, l'Hb et les plaquettes sont normales. Quelle est la prochaine thérapie ?

- a) Chimiothérapie
- b) Immunothérapie
- c) Bloc opératoire
- d) oxygénation hyperbare
- e) Administration d'antibiotiques

103. Un patient de 50 ans avec un IMC de 50 se présente à votre cabinet avec une douleur de type brûlures au pied. Il est connu pour une hypercholestérolémie et une hypertension. Il souffre d'une hyperkératose sur la plante du pied et d'un petit ulcère peu douloureux sous le talon. Quel diagnostic permet de clarifier l'étiologie de ses douleurs ?

- a) Radiographie du pied
- b) HbA1c
- c) IRM du pied
- d) US-Doppler des artères de la jambe
- e) CRP

104. Un patient de 30 ans se plaint depuis trois semaines de diarrhées et de douleurs dans la fosse iliaque droite. Il n'y a pas d'autres symptômes, la question des symptômes B reçoit une réponse négative, sinon le patient se sent en bonne santé. L'anamnèse prolongée est blanchie. L'examen clinique montre une légère tension défensive diffuse de la paroi abdominale sans douleur de libération. Sinon, l'examen clinique est improductif, surtout il n'y a pas de fièvre ou de jaunisse. Quel est le diagnostic le plus probable sur la base des symptômes et des résultats mentionnés ci-dessus ?

- a) Pancréatite
- b) Appendicite
- c) Carcinome du côlon
- d) M. Crohn
- e) M. Whipple

Abcès scrotal
Follicule pileux
G. de Fournier

105. Un homme de 33 ans se présente aux urgences, après s'être battu dans une foire. Il a été frappé d'un poing sur le côté gauche de son visage. Les antécédents du patient sont adéquats et ne montrent aucune anomalie neurologique. Il a un hématome palpébral qui ne permet pas un examen ophtalmologique du côté affecté. En outre, la pommette est bosselée sur le côté gauche. La sensibilité de la lèvre supérieure est réduite. Quelle est la prochaine étape ?

- a) Suivi
- b) Déterminer la CRP et l'Hb
- c) CT crâne facial
- d) Consultation ophtalmologique
- e) Consultation neurologique

BPCO exacerbation

106. Un patient atteint de BPCO est amené aux urgences en ambulance. Le patient est somnolent et ne réagit donc pas de manière adéquate. Il est immédiatement scopé, les paramètres vitaux suivants se distinguant : TA : 80/50 mmHg, FC : 121, FC: 22. Au cours de la surveillance, l'infirmière en charge a également pu prendre un gazo (bravo super), qui indiquait une insuffisance respiratoire partielle et un pH légèrement réduit. Elle a également remarqué une légère augmentation de la créatinine et du lactate. Vous effectuez un examen physique rapide et orienté et vous découvrez un patient cachectique qui ne présente pas d'œdème des membres inférieurs. Quelle est la prochaine étape thérapeutique pour ce patient ?

- a) Perfusion de NaCl à 0,9%
- b) Infusion d'antibiotiques
- c) Adrénaline
- d) CT thorax
- e) **Ventilation non invasive**

107. Une femme de 90 ans tombe sur son bras droit et se fracture l'humérus. Lors de l'examen clinique, elle ne peut pas effectuer de flexion dorsale de ses doigts ou son poignet Quel est le nerf endommagé ?

- a) N. Axillaris
- b) N. Ulnaris
- c) N. Radialis
- d) N. Medianus
- e) N. Musculocutaneus

108. Une fillette de 4 ans se présente chez le pédiatre accompagnée de ses parents. Les parents sont inquiets car l'enfant n'a pas pris de poids depuis le changement de régime après la 2e année de vie. Jusqu'alors, l'enfant avait eu un développement normal. Les parents nourrissent leur enfant en fonction de son âge et sans restriction et prennent soin de leur enfant avec amour. Les maladies ne sont pas connues dans la famille, la mère mesure 158 cm, le père 179 centimètres. La circonférence de la tête de la jeune fille est normale (50 Percentile), la hauteur et la longueur sont inférieures au 3ème percentile. Quelle est la cause la plus probable du retard de croissance ?

- a) Le nanisme constitutionnel
- b) Malabsorption
- c) Malnutrition
- d) aberration chromosomique
- e) Négligence

109. Un motocycliste de 26 ans a eu un accident avec impact sur le côté antérolatéral gauche de la jambe inférieure. Il est admis aux urgences en ambulance. Lors de l'examen clinique, le pied gauche est douloureux, chaud, et impressionnant. Les pulsations du pied sont palpables, mais les mouvements actifs et passifs des orteils ne sont pas possibles en raison de douleurs intenses qu'ils engendrent. Où se trouve la lésion et qu'est-ce qui provoque ces symptômes ?

- a) Fracture transversale de l'axe médian du tibia
- b) Rupture de l'artère tibiale postérieure
- c) les lésions du nerf péronier commun
- d) Rupture du ligament croisé antérieur
- e) Syndrome des loges antérieur

110. Un homme de 70 ans, qui consomme régulièrement de l'alcool et fume, vomit depuis 24 heures et souffre de dysphagie depuis 5 jours. Il a perdu 12 kg au cours des deux derniers mois. L'imagerie montre un estomac distendu. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Carcinome épidermoïde de l'œsophage
- b) l'adénocarcinome du pylore
- c) Adénocarcinome du jéjunum
- d) l'adénocarcinome du cæcum
- e) Cholangiocarcinome

111. Une femme obèse de 40 ans se présente à son médecin de famille avec une fièvre qui existe depuis 2 jours et des douleurs abdominales supérieures croissantes du côté droit. Elle déclare ne pas avoir voyagé récemment. L'examen physique est peu visible, à l'exception d'une dolence de pression dans le quadrant supérieur droit. Quelle est la méthode de diagnostic la plus appropriée pour clarifier les éventuels diagnostics différentiels ?

- a) Échographie de l'abdomen
- b) Prélèvement de sang avec CRP et leucocytes
- c) Doppler de la vaisseaux porte
- d) Sérologie de l'hépatite
- e) Examen rectal digital

112. Lors de l'examen de routine d'un patient de 58 ans, vous ausculté un souffle abdominal. L'échographie permet de diagnostiquer un anévrisme de l'aorte infrarénale avec un diamètre de 4,3 cm. Le patient est surpris par ce diagnostic, car il n'a remarqué aucun signe nouveau. Sinon, le patient est en bonne santé et ne se plaint plus. Quelle est votre procédure ultérieure pour le patient ?

- a) L'angiographie par résonance magnétique
- b) Orientation vers la chirurgie vasculaire
- c) Suivi échographique dans 6 mois
- d) CT abdomen avec KM
- e) Echocardiographie

113. Un agriculteur de 80 ans vient vous voir dans le cabinet du médecin de famille. Depuis plusieurs mois, il a remarqué plusieurs plaques rugueuses sur le cuir chevelu chauve, qu'il aimerait faire examiner par vous lors de l'examen de routine. Vous observez une hyperkératose sur un fond érythémateux. Parmi les traitements mentionnés ici, lequel est indiqué pour cette constatation ?

- a) Stéroïde topique
- b) Agent antifongique topique
- c) Antibiotique topique
- d) Excision avec distance de sécurité
- e) Photothérapie

114. Un patient de 72 ans souffrant, entre autres, d'un diabète sucré de type II de longue date et d'hypertension, a développé une insuffisance rénale chronique au fil des ans avec un DFG actuel selon la formule de Cockcroft-Gault de 35 ml/min/1,73m². Il a maintenant besoin d'une thérapie analgésique avec de la morphine en réserve.

Comment devez-vous procéder en ce qui concerne le dosage de la morphine chez ce patient et quelle est la base décisive de votre action ?

- a) Ne pas ajuster la dose, car la morphine est métabolisée par le foie
- b) Ne pas ajuster la dose car son DFG n'est pas inférieur à 30 ml/min
- c) Ne pas ajuster la dose car il n'utilise la morphine qu'en cas de besoin
- d) Ajuster la dose car la morphine est néphrotoxique
- e) Ajuster la dose parce que les métabolites sont excrétés par voie rénale

115. Une femme de 26 ans se présente aux urgences chirurgicales de l'hôpital situé près de l'aéroport durant le week-end. Elle se plaint de douleurs abdominales 2 jours après son arrivée d'Amérique. Cependant, elle n'a aucun problème de miction ou de selles. Cependant, en raison du voyage, son cycle n'est plus régulier (normalement 29-31 jours), de sorte que son dernier "vrai" saignement remonte à 7 semaines. Que devez-vous faire ensuite ?

- a) Abdomen CT
- b) Bêta-hCG dans les urines
- c) Bêta-hCG dans le sérum
- d) Échographie transvaginale
- e) Laparoscopie exploratoire

116. Un patient de 76 ans vous est adressé par la maison de retraite parce qu'il se comporte bizarrement ces derniers temps, parfois par dérangement verbal envers le personnel. Il mange aussi de moins en moins, car il craint d'être empoisonné pour qu'on lui vole son argent. Il voit aussi des personnages en manteau noir avec des porte-documents argentés qui se tiennent autour de son lit la nuit. L'examen neurologique montre une symptomatologie rigide hypokinétique avec hypomimie, démarche à petits pas et tremblement au repos de la main droite. Le MMS est pathologique (17 points). Quel est le diagnostic le plus probable pour ce patient ?

- a) Démence frontotemporale
- b) La démence d'Alzheimer
- c) Démence à corps de Lewy
- d) Dépression avec symptômes psychotiques
- e) Trouble de la personnalité instable

117. Un patient est trouvé allongé dans la rue par l'ambulance et le médecin urgentiste. Les paramètres vitaux suivants sont obtenus sur place : T : 35,1 °C TA : 85/45 mmHg, FC : 50/min, FR : 8/min. Au cours de l'examen clinique, ils découvrent que le patient est somnolent. Il présente une hyporéflexie, les pupilles sont bilatéralement en myosis de manière uniforme. Lequel des médicaments mentionnés ici le médecin urgentiste doit-il administrer en urgence ?

- a) Atropine
- b) Naloxone
- c) Flumazenil
- d) le lorazépam
- e) la physostigmine

118. Un patient de 80 ans rend visite à son médecin en raison d'une douleur brûlante dans la bouche. Une candidose orale a été traitée lege artis. Néanmoins, une partie de la lésion demeure (voir photo)



Quelle est votre procédure ultérieure en tant que médecin traitant ?

- a) L'antibiothérapie
- b) Orientation vers la chirurgie buccale
- c) Rince-bouche désinfectant
- d) Traiter à nouveau l'antifongique
- e) Suivi dans 3 mois

119. Une patiente atteint d'un carcinome mammaire métastatique présente une nouvelle apparition de dyspnée, ainsi qu'une augmentation de la circonférence du cou, un enrouement de la parole et des veines du cou congestionnées. La patiente est tachycarde, la pression artérielle diminue en inspiration à 80/60 mmHg, la pression artérielle en expiration est de 130/70 mmHg. L'ECG montre un microvoltage. Le diagnostic suspecté a été confirmé par l'écho.

Quel traitement est maintenant indiqué ?

- a) Diurétiques
- b) Les bêta-bloquants
- c) Ponction pleurale
- d) la péricardiocentèse
- e) Médicaments inotropes positifs

120. Une patiente de 53 ans connue pour un cancer du sein traité opéré il y a 7 ans (actuellement traité par SERM) avec une ostéoporose manifeste (ostéodensitométrie pathologique et fracture spontanée du corps vertébral) prend du calcium et de la vitamine D3 pour consolider ses os. Que pourriez-vous prendre d'autre pour ralentir la progression de l'ostéoporose ?

- a) Prednisone
- b) Oestrogène transcutané
- c) le sulfate de chondroïtine
- d) Bisphosphonates
- e) L-thyroxine

121. Un patient de 55 ans, originaire du Burkina Faso et vivant en Suisse depuis 10 ans, a fait état de fatigue pendant 6 mois et de toux pendant deux semaines, ainsi que d'une perte de poids de 10 kg sur 6 mois. Il consommait autrefois de l'alcool et du tabac, mais s'en est depuis éloigné. L'auscultation pulmonaire entraîne une hypoventilation du côté gauche. Dans la radiographie du thorax, vous pouvez voir l'image suivante :



Qu'est-ce qui expliquerait le plus probablement le tableau clinique ?

- a) Tuberculose
- b) Néoplasie
- c) Pneumocystis jirovecii
- d) l'aspergillose
- e) Pneumonie d'une autre étiologie

122. Un patient de 29 ans est diagnostiqué pour une syphilis lors du don de sang. Rétrospectivement, il rapporte un ulcère du scrotum de 6 mois, qui a guéri spontanément. Il n'a actuellement aucune plainte à formuler. La sérologie correspond à un stade précoce de la syphilis. Il est traité à la pénicilline G par voie intramusculaire. Et six mois plus tard, à l'issue du suivi, il ne présente toujours pas de symptômes.

La sérologie montre ce qui suit :

RPR :

- Mars 2018 : 1:16
- Sept 2018 : 1h:32
- Norme : <1:8

TPPA :

- Mars : 40>000
- septembre : 20>000
- Standard:> 1 :80

FTA-ABS IgM titre :

- Mars : >3,5
- Sept : >3,5

Quelle est votre prochaine étape ?

- a) Ponction lombaire
- b) répéter la pénicilline G im.
- c) Pénicilline G iv.
- d) diagnostic de Borrelieose
- e) Sérologie de suivi dans 12 mois

123. Un garçon de 3 ans est accompagné chez le pédiatre en raison d'une fièvre de 39°C et de maux de tête pendant trois jours. L'examen clinique révèle une gorge rougie, des ganglions lymphatiques cervicaux indolents et hypertrophiés et une légère résistance à la flexion du cou. Quelle est votre prochaine étape ?

- a) Hémocultures
- b) Ponction lombaire
- c) un prélèvement de gorge et de la pénicilline pendant 10 jours po.
- d) Test de détection des anticorps hétérophiles
- e) prélèvement de gorge, numération leucocytaire et suivi dans les 24 heures

124. Un cadavre de 80 ans est trouvé dans une pièce fermée avec un four à gaz. Aucune lésion externe est visible sur le corps. Quels sont les signes typiques d'un empoisonnement au monoxyde de carbone ?

- a) Vomissements sur et autour du cadavre
- b) Odeur d'amandes amères
- c) Lividités rouge vif
- d) Odeur de pommes pourries
- e) Rigidité cadavérique

125. Une patiente de 42 ans rapporte qu'elle a remarqué une nouvelle contraction musculaire. Au cours de l'examen, elle a observé une contraction involontaire du coin de sa bouche lorsqu'elle tapait sur sa joue. Quelle est la cause de ce signe clinique ? (K-prim)

- a) l'hypokaliémie
- b) Hyperkaliémie
- c) Hypocalcémie
- d) hypercalcémie

126. Un jeune patient se présente aux urgences il y a deux heures après une dispute. Il avait subi une blessure par morsure de son adversaire, qui est de 2 cm de large et située dorsalement sur l'avant-bras. La blessure a été étendue, rincée et le tissu avital a été nécrotique. Quelle est la suite de la procédure :

- a) Cortisone p.o.
- b) les antibiotiques par voie intraveineuse
- c) les antibiotiques p.o.
- d) Couture de la plaie
- e) Exciser grossièrement la plaie

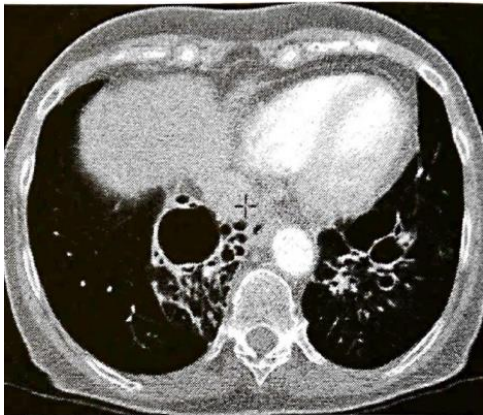
127. Vous êtes un nouvel assistant dans un service de médecine interne. Un patient de 36 ans atteint de cholécystite y est hospitalisé. Il est entré et sorti des services psychiatriques pour dépendance à l'alcool. Grâce à votre entretien motivationnel avec le patient, vous avez pu le convaincre d'arrêter de boire. Il veut maintenant savoir quels médicaments supplémentaires il pourrait prendre pour éviter une rechute.

- a) les benzodiazépines
- b) la méthadone
- c) l'escitalopram
- d) Acamprosate
- e) Lévodopa

128. Une femme de 60 ans se présente à son médecin de famille avec des irrégularités de transit et du sang frais dans ses selles. Lequel des examens mentionnés ci-dessus doit être effectué avant les autres examens ?

- a) un toucher rectal
- b) CT abdomen
- c) La coloscopie
- d) les marqueurs dans le sang CEA
- e) Gastroskopie

129. Un patient connu pour un déficit en alpha 1 antitrypsine se présente en urgence à cause d'une hémoptysie. Sur la CT vous voyez ceci : Image CT :



Quel est son diagnostic ?

- a) Pneumonie
- b) Bronchiectasie
- c) LE
- d) L'épanchement pleural
- e) Tumeur

130. Nous sommes en décembre. Une jeune femme disparaît sans laisser de traces après un dîner de fondue avec des amis et n'est retrouvée que le lendemain matin : Elle est allongée sur le bord de la route, partiellement déshabillée. Dans son sac, il y a un paquet de benzodiazépines partiellement ouvert. A quoi devez-vous veiller principalement pendant l'examen ? (K-Prim)

- a) l'hypothermie
- b) les abus sexuels
- c) l'intolérance alimentaire
- d) Épilepsie

131. Une fillette de 5 ans souffre de douleurs au genou gauche et boite depuis 24 heures. Le genou gauche est chaud et présente des douleurs à la palpation. Lors de l'examen, vous retrouvez un signe du glaçon. L'enfant tient sa jambe gauche dans une position de flexion de 20 degrés et la distance talon-fesse est de 5 cm. Parmi les diagnostics différentiels suivants, lequel nécessite l'intervention la plus urgente ?

- a) Borréliose de Lyme
- b) Infection à Parvo B19
- c) L'arthrite septique
- d) Arthrite post-infectieuse
- e) L'arthrite idiopathique juvénile

132. Un homme de 62 ans, atteint d'une BPCO connue et d'un cancer du poumon métastatique, est traité par une chimiothérapie palliative. Après le début du deuxième cycle de traitement, il développe une fièvre et une baisse de l'EG. Pression artérielle basse, pouls élevé, mauvaise saturation. La numération globulaire montre une agranulocytose.

Qu'est-ce qui est indiqué ensuite ?

- a) Analgésie et paracétamol par voie orale et à domicile
- b) Antibiotiques per os et retour à domicile
- c) Co-Amox : i.v. et hospitalisation
- d) Cefepim i.v. et hospitalisation
- e) Antimycosiques i.v. et hospitalisation

133. Un patient de 67 ans en bon EG et sans antécédents de maladie est en salle de réveil après une opération d'une hernie il y a une heure. Il développe maintenant une hypoxémie (88% en dessous de 4L d'O₂ /min). A la base gauche, on entend un bruit de respiration affaibli. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Atélectasie
- b) EP
- c) Obstruction trachéale
- d) la pneumonie par aspiration
- e) Bradypnée induite par les opiacés

Questions avec informations incomplètes

134. Un homme de 30 ans a été traité par psychothérapie et paroxétine pendant 9 mois pour cause de dépression. Comme il va maintenant nettement mieux, il abandonne la paroxétine de son propre chef. Quatre jours plus tard, il se présente chez son médecin de famille en raison de vertiges et de douleurs musculaires. Il est également nerveux, irritable et fébrile à 40°C . Quelle est la cause la plus probable de ses symptômes ?

- a) Syndrome grippal
- b) Le syndrome de sevrage
- c) Hyperthermie maligne
- d) Syndrome sérotoninergique
- e) Syndrome neuroleptique malin

135. Homme de 49 ans atteint d'une hépatite C connue et abus de drogues i.v. consulte dans le cadre du programme de méthadone. Transaminases élevées pendant environ 1 an, sinon sans problèmes de médecine interne. Fatigue, mais pas de perte de poids.

L'abdomen est sans importance. Diarrhée et constipation intermittentes.

Quelle est la prochaine étape ?

- a) La coloscopie
- b) Biopsie du foie
- c) test de sang occult dans les selles
- e) Test de l'antigène de l'hépatite C

136. Petit garçon (9 ans) , revient de vacances avec la famille au Sénégal , après une semaine à la maison sont fébriles et la diarrhée. Ce qui est fait (Kprim) :

- a) La culture des selles
- b) Test de parasites
- c) test de dépistage de la dengue
- d) l'antibiothérapie

137. Un patient est amené aux urgences. Son visage, ses lèvres et sa langue sont très enflés. Le patient reçoit une greffe de rein et suit une thérapie à la prednisone, à la ciclosporine et au mycophénolate mofétil. En laboratoire, on observe une leucocytose de 14,0 lg/l.



Quelle thérapie est immédiatement indiquée ?

- a) Antibiotiques à large spectre par voie intraveineuse
- b) Antihistaminiques et corticostéroïdes i.v.
- c) Enregistrement et observation
- d) Plasma frais congelé
- e) Substitution de l'inhibiteur de la C1 estérase

138. Un alcoolique de 55 ans est retrouvé désorienté, allongé devant les urgences de l'hôpital. Auparavant, il avait été amené à la clinique ORL en raison de maux d'oreille sur le côté gauche et de symptômes de rhume. Lors de l'examen d'admission, il est normotendu (118/79 mmHg) et normocarde, température 37,8°C. Il est actuellement conscient, mais désorienté. Dans l'état, un méningisme terminal peut être déterminé. Lors de l'examen neurologique complémentaire, aucune autre anomalie n'est constatée. Quel diagnostic suspect a la plus forte influence sur la procédure diagnostique/thérapeutique ultérieure ?

- a) Otite externe
- b) la méningite bactérienne
- c) Otites moyennes
- d) Thrombose du sinus veineux

2019 Réponses

1. e) La granulomatose de Wegener entre également en ligne de compte, mais le pic de l'âge n'est atteint qu'à partir de 40 ans.
2. b) Créatinine normale et sténose <60%. Pas d'indication de PTA. (enclume, sténose de l'artère rénale)
3. a) Les inhibiteurs de l'ECA sont absolument contre-indiqués pendant toute la grossesse. (embryotox.de), antagonistes du calcium présentent un risque de tocolyse et ne sont recommandés qu'en tant qu'antihypertenseur de 2e choix au 1er trimestre.
4. a)
5. d) Éviter les radiations et les produits de contraste pendant la grossesse. (Radiologie USZ, Imagerie pendant la grossesse.)
6. c) Niveau 2 Traitement de l'asthme : SABA (bêta-mim.) plus corticostéroïde inhalé (medix.ch, Asthmaguidelines)
7. b) Vacciner 2x, intervalle d'au moins un mois. (medix.ch, informations pratiques sur le plan de vaccination suisse 2019)
8. e) pancréatite alcoolique avec élévation des gamma-GT et de la lipase. (Enclume, Pancréatite aiguë, Diagnostic)
9. c) L'acidose lactique parle en faveur de l'ischémie. (enclume, occlusion de l'artère mésentérique)
10. +++-
11. a) Hypoglycémie en cas de diabète : <3.9mmol/L. Le traitement par insuline à action prolongée doit être basé sur le poids corporel. doit être ajustée. En cas de perte de poids et de prise alimentaire insuffisante, la dose d'insuline doit être adaptée. être.
12. a) L'agoraphobie se caractérise par la peur d'aller seul dans les lieux publics et de se déplacer seul dans les transports. se déplacer, au premier plan (enclume, agoraphobie)
13. d) Les effets indésirables du méthotrexate incluent la stomatite (Compendium, Methotrexat, Effets inattendus)
14. b) Le Röntgen montre un épanchement pleural du côté droit et un épaississement pleural. Pas de foyer primaire dans la poumons visibles.
15. d) Ophtalmoscopie : toxoplasmose oculaire : foyers blancs jaunâtres, méningite bactérienne : papille congestive, hydrocéphalie : Papille congestive, traumatisme du tibia : "Des hémorragies rétinienne prononcées chez un enfant parlent très clairement d'une Maltraitance infantile" (enclume, maltraitance infantile), rétinoblastome : tumeur rétinienne vascularisée gris-blanc
16. +-+
17. b) un écoulement grisâtre est plutôt un signe de trichomonas, d'où l'utilisation de lames porte-objets (enclumes, inflammations de l'appareil génital féminin).
18. a) Herpès zoster oticus probable. Vésicules sur l'oreille. (Enclume, Zoster oticus)
19. a) L'hémogramme indique une leucémie. LMC : translocation t(9;22) vers le gène de fusion BCR-ABL oncogène.
20. e) (Amboss, CML) La dermatite atopique est un diagnostic clinique (Amboss, Atopic Dermatitis)
21. b) Crampes dans les mollets <pour cause de perte d'électrolytes (hypocalcémie, hypomagnésémie, hyponatrémie)
22. b) possible sous diurétiques. Pas de manifestation clinique. Sonographie imagerie primaire pour les nodules de la
23. c) thyroïde. (enclume, goitre) Le poids en dessous du 10e percentile est un poids insuffisant. Le plus probable c)
24. d) Image d'un œil droit avec ptérygion (en allemand : Fli.igelfell). Large base partant de l'angle médian de l'œil. (Enclume, ptérygion conjonctival)
25. c) Déclaration dans les 24h en cas de triade clinique (fièvre, exanthème maculopapuleux, toux/rhinite/conjonctivite) ou de résultat de laboratoire positif (OFSP, Guide de la déclaration obligatoire 2020)
26. a) Image d'une hernie hiatale. Opération indiquée (enclume, hernie hiatale)
27. e) HOCM comme cause la plus fréquente de mort cardiaque subite avec agrégat familial. (enclume, CMH)
28. e) DD annexite, DD kyste ovarien, DD endométriose, DD PCO, diagnostic dans tous les cas en premier lieu par échographie vaginale (enclume, diagnostic en gynécologie)
29. a) Passage gastrique 1-6h, donc pas de cabossage, pas de charbon actif (seulement pour les toxines liées à l'intestin), acétylcystéine en fonction des valeurs hépatiques et du taux de paracétamol (MSD Manual, intoxications au paracétamol)
30. ++++ (allergie de type I)
31. a) EEG pour exclure un état de mal épileptique potentiellement mortel. (Enclume, Épilepsie, Diagnostic)
32. a)
33. e) (KSA, pose de Mirena, contrôles)
34. b) Rétinoblastome choroïdien : Funduscopie : tumeur en relief, pigmentation variable, souvent brune. Symptomatique : perte du champ visuel <par décollement de la rétine dû à la tumeur (enclume, mélanome de la choroïde)
35. d) La symptomatologie est le plus souvent en faveur d'un syndrome sérotoninergique (compendium, paroxétine,
36. c) effets indésirables) Traitement primaire de choix de tous les carcinomes des artères thyroïdiennes > 1cm (enclume,
37. c) carcinome de la thyroïde, traitement) L'ADPKD est un facteur de risque pour les hémorragies sous-
38. e) arachnoïdiennes non traumatiques (enclume, hémorragie sous-arachnoïdienne) Coma hyperosmolaire dû à un manque d'insuline chez une diabétique de type 2, le tableau clinique dépendant de l'état de santé. déshydratation et de la perte d'électrolytes. (Enclume, Coma hyperosmolaire)
39. d) Le syndrome de compartimentation se manifeste généralement au début <par des douleurs intenses qui ne répondent pas aux analgésiques.

Le pouls artériel ne s'arrête généralement qu'en cas de syndrome du compartiment très grave
(Syndrome du compartiment de l'enclume, symptômes/clinique)

40. b) La symptomatologie est le plus souvent <déclenchée par une métastase dans la région de la colonne vertébrale lombaire et correspond à un syndrome de la cauda equina : symptômes asymétriques, absence de réflexes des membres inférieurs, douleurs radiculaires, etc. (Wikipedia, syndrome de la cauda equina)
41. b) En cas de palpation anormale, une mammographie et une échographie sont généralement effectuées en premier lieu pour clarifier la situation. (Enclume, Carcinome mammaire, Diagnostic)

42. c) Diagnostic d'exclusion : Rontgen en cas de Vd. a. Embolie pulmonaire n'est pas judicieux, de même que le scanner abdominal/pelvien. La scintigraphie est plus irradiante que le scanner thoracique. Par conséquent, le plus probable est c)
43. ++-+ Diplocoques dans le frottis : gonorrhée. (OFSP, Gonorrhée / Enclume, Gonorrhée)
44. d) Evolution paradique de la maladie, crépitation : le plus probable est la gangrène gazeuse <par Clostridium perfringens.
45. b) (Doccheck, gangrène gazeuse) Démangeaison articulaire avec dépôt de cristaux de pyrophosphate de calcium :
46. b) chondrocalcinose (pseudogoutte)
47. d) Carie dentaire <par des vomissements récurrents.
Diagnostic par exclusion. Il s'agit le plus souvent d'un zona débutant. L'érythème et les vésicules ne se forment qu'environ 4 jours après le début de la maladie.
48. b) Angio-TDM avec de multiples prises de contraste paracentrales, ainsi qu'une obstruction sous-pleurale en forme de coin.
La profondeur de l'infiltration est centrale dans la détermination du stade UICC et donc déterminante pour le traitement et le pronostic. (Enclume, Carcinome colorectal)
50. c) Le carcinome basocellulaire et le chalazion ne sont généralement pas douloureux, la dacryocystite et la dacryoadénite sont douloureuses, mais localisées sur la paupière inférieure médiale (cystite) ou sur la paupière supérieure (adénite). (enclume, inflammation des paupières / inflammation de l'appareil transténien)
51. e) Pour les plaies infectées, un traitement ouvert est le plus souvent indiqué. (Enclume, Traitement des plaies, Traitement des plaies ouvertes)
52. b) protrusion circulaire prolongée de la muqueuse, lubrification des selles, faiblesse du sphincter anal -> prolapsus rectal (enclume, prolapsus anal et rectal)
53. e) La natation sollicite moins les os et est donc moins indiquée pour la prophylaxie de l'ostéoporose. (osv-ev.org,
54. c) Ostéoporose, Connaissance de l'ostéoporose)
Douleurs locales de la colonne vertébrale thoracique chez une patiente âgée. Aucune symptomatologie radiculaire
55. a) décrite. Fracture la plus probable : ostéoporotique. (enclume, fracture du corps vertébral)
56. d) Hémorragie rétinienne, hamatome sous-dural -> Syndrome de Shaken-Baby (enclume, syndrome de Shaken-Baby) Exanthème non prurigineux en plusieurs endroits du corps ainsi que par voie orale.
57. a) Diagnostic différentiel syphilis secondaire/sarcome de Kaposi. (Enclume, syphilis secondaire/ Wikipedia, sarcome de Kaposi)
L'IFN-β a des propriétés immunomodulatrices et peut donc augmenter le risque d'endocardite. Un
58. c) souffle systolique au-dessus de la valve mitrale, une insuffisance rénale (glomérulonéphrite) et une attaque cérébrale seraient compatibles. (Enclume, Endocardite infectieuse, Symptômes)
59. e) L'hyperkaliémie est une indication pour la dialyse aigue. L'acidose aussi, mais l'indication est donnée
60. c) lorsque le pH est <7,2. (Enclume, Procédure de remplacement rénal, Dialyse)
Insuffisance rénale prénale la plus probable due à une déshydratation en cas de diarrhée. (enclume, déshydratation)
61. a) A l'âge de 13 ans, la jeune fille se trouve dans une phase de puberté précoce. La puberté commence
62. b) normalement vers 11 ans. C'est pourquoi il s'agit le plus souvent d'un retard de croissance constitutionnel. (Enclume, puberté tardive)
63. e) Les inhibiteurs de l'ECA ne doivent pas être utilisés pendant toute la grossesse. (embryotox.de)
64. a) Amaurosis fugax en cas d'artérite à cellules géantes/polymyalgia rheumatica. -> Traitement par
65. b) glucocorticoïdes à haute dose. (Enclume, Amaurosis fugax)
66. b) Métamorphopsie, patient âgé : dégénérescence maculaire liée à l'âge (enclume, dégénérescence maculaire liée à l'âge)
67. c) Un traumatisme mécanique peut déclencher une fibrillation ventriculaire (enclume, flutter et fibrillation ventriculaire, étiologie) (Doccheck, hamatome sous-unguéal)
Perte de poids, dyspnée progressive, hémoptysie, 60Py -> le plus probable est un cancer bronchique.
68. b) Morphologie classique d'une kératite dendritique (kératite épithéliale) : érosions superficielles de la cornée en forme d'arbre, <facilement visible par coloration à la fluorescéine.infection <par le VRS réactivé. CAVE : les glucocorticoïdes sont contre-indiqués en cas de kératite dendritique ! (enclume, kératite dendritique)
69. d) Patient souffrant d'IVC (insuffisance veineuse chronique). L'étalon-or en matière de diagnostic est l'échographie duplex. Alternative : phlébographie. CAVE : il est impératif de vérifier la perméabilité du système veineux profond avant toute intervention ! (Enclume, IVC, Diagnostic)
70. d) Sonographie FAST après un traumatisme
71. d) Patient avec vd. a. infarctus mésentérique aigu et jéjunum/iléon éventuellement ischémie du gros intestin (thrombus, embolie en cas de fibrillation auriculaire). Diagnostic gold standard : angio-TDM-abdomen. CAVE : en cas de péritonite ou de risque de choc, une opération d'urgence sans diagnostic appareillé peut être nécessaire ! (Enclume, Infarctus mésentérique, Diagnostic)
72. a) Patient présentant une hypothyroïdie primaire iatrogène et une symptomatologie classique. EI de l'amiodarone. Rémission spontanée de l'hypothyroïdie après 3-4 mois après l'arrêt du médicament. (compendium, Amiodarone)
- 73.+++--+ Staging du cancer du côlon et du rectum : L'IRM pelvienne (détermination de la distance entre la tumeur et le fascia mésorectal), le marqueur tumoral CEA (valeur initiale avant le début du traitement), le scanner thoracique/abdominal (détection des métastases). La rectoscopie rigide pour déterminer la distance entre le carcinome et le sphincter (linea dentata) (planification du traitement et maintien de la continence). L'endosonographie rectale (profondeur d'infiltration). (enclume, cancer du côlon, staging)

74. d) La giardiase est surtout présente dans les régions subtropicales et tropicales. DD : Amobiase : ferait une diarrhée sanglante (comme de la gelée de framboise) et des abcès du foie. Côlon irritable comme diagnostic d'exclusion. (enclume, giardiase)
- 75.--++ DDs Troubles de la croissance chez le nouveau-né. Transglutaminase-AK pour exclure la zoliakie (L'allaitement à 2 mois n'est pas recommandé, car l'alimentation se fait au lait maternel). Le test de la sueur pour détecter un dysfonctionnement du CFTR. Rx du médiastin utile pour évaluer les lymphomes ou les processus compressifs sur la trachée.

76. c) Mauvaise hygiène buccale, mauvaise haleine, dysphagie : patiente suspectée d'un carcinome de l'amygdale ulcéreuse. (enclume, carcinome de l'amygdale)
77. e) Récepteurs hormonaux du carcinome mammaire : récepteurs des œstrogènes (ER) et de la progestérone (PR), statut HER2, Indice de prolifération Ki-67. La cadhérine 17 est un marqueur tumoral diagnostique pour les adénocarcinomes du tractus gastro-intestinal. (Enclume, Carcinome mammaire, Pathologie)
78. b) Opérabilité du patient : La sténose de la valve aortique est d'abord traitée par TAVI, car il s'agit d'un patient âgé. patients présentant un risque opératoire élevé. La prothèse Hlift est ensuite mise en place. En cas de combinaison d'opérations, les facteurs de risque se multiplient, en cas de deux opérations séparées, ils ne font que s'additionner. (dixit le chef du service de traumatologie, Triemli)
79. b) réaction transfusionnelle hamolytique de type immédiat. Traitement : arrêt immédiat de la transfusion et documentation des préparations sanguines. Traitement ultérieur des complications (choc, insuffisance rénale, etc.) (enclume, réactions transfusionnelles)
80. a)
81. b) Clarification en cas de vd. a. Hyperthyroïdie, le cas échéant <par un traitement substitutif trop fortement dosé.
82. d) CP Art.119(2) : Interruption de grossesse non punissable dans les 12 semaines après un entretien personnel avec un médecin, CP Art 120c : En dessous de 16 ans, un entretien supplémentaire avec un centre de consultation spécialisé doit avoir lieu. (admin.ch, Code pénal suisse)
83. d) Hydrocèle testiculaire : accumulation indolore de liquide entre les hiles testiculaires séreux dans le scrotum. Lors de la diaphonoscopie, la lumière de la lampe froide semble rougeâtre <transparente. (enclume, hydrocèle testis)
84. b) (medstandards.ch, Anaphylaxie)
85. c) Une prophylaxie de l'endocardite est indiquée chez les patients ayant subi un remplacement valvulaire, une endocardite post-opératoire, des malformations cardiaques et du matériel prothétique. (Enclume, prophylaxie de l'endocardite)
86. e) "Si, en l'absence de traitement, il existe un risque d'atteinte grave à la santé ou de mise en danger sérieuse de l'intégrité physique ou de la vie d'autrui". (kesb-zh.ch, Placement Fiirsorgliche)
87. b) décès incertain (l'identité du corps ne peut pas être établie) (irm.unibe.ch, notice sur l'examen médical du corps)
88. a) Le retard de développement constitutionnel (RPC) est la deuxième cause la plus fréquente de petite taille et se manifeste par un retard de puberté. Le retard de croissance est souvent familial. (Doccheck, Retard de développement constitutionnel)
89. b) TDM pour exclure une fracture de l'os temporal en cas de chute sur le visage (fracture d'éclatement dans le cadre d'un polytraumatisme ou d'un traumatisme crânien). Cave : la fuite de liquide céphalo-rachidien peut être testée par la présence de bêta2-transferrine.
- 90.++++ rhinosinusite chronique DD : maladie de Widal (triade de Samter en cas d'intolérance aux ASS ou aux AINS), rhinite allergique, asthme bronchique, rhinosinusite chronique à éosinophiles avec multiples polypes nasaux (enclume, sinusite)
91. d) DD Troubles de la croissance chez l'enfant. Zoliacie avec âge de manifestation typique (fin de l'âge de la tétée) Symptômes : ventre de tambour, diarrhée et perte d'appétit/malabsorption. Traitement : régime sans gluten à vie. (enclume, entéropathie sensible au gluten)
92. b) Vd.a. Tachycardie supraventriculaire (AVNRT fréquente au jeune âge)-> Adénosine pour le diagnostic différentiel et éventuellement la thérapie. (swissmedicalforum, tachycardie supraventriculaire)
93. e) En cas de luxation, une déformation est visible. L'abduction est réalisée par le muscle supra-épineux. Les muscles supraspinatus, infraspinatus et teres minor effectuent une rotation externe. -> Couverture de la coiffe des rotateurs (enclume, érosion des tissus mous de l'épaule)
94. c) suspicion de rupture d'un kyste ovarien fonctionnel. Sonographie vaginale : limites lisses de tous les côtés, singulières ou multiples, peu ou pas d'écho, le cas échéant avec formation de miroirs. DD : annexite : gonflement de l'annexe à l'US, DD : appendicite : phanomes en cocarde à l'US.
95. c) Syndrome de Guillain-Barre : auto-anticorps contre la myéline et les gangliosides souvent après une infection virale ou bactérienne (généralement Campylobacter jejuni), idiopathique dans 1/3 des cas. (Enclume, syndrome de Guillain-Barre, étiologie)
96. e) Procéder selon le schéma ABCD : intubation, drain thoracique, acide tranexamique, scanner du corps entier.
97. c) Patient (50py) avec insuffisance respiratoire globale (pO2 abaissée, pCO2 augmentée). -> Vd. a. BPCO. Les toux avec expectorations gliniques, les râles bronchiques et la dyspnée indiquent une infection. -> BPCO exacerbée (enclume, BPCO)
- 98.--++ Patella relevée : ratio Insall Salvati >1.3 (radiopedia.de, patella alta), indice indirect Epanchement articulaire : transparence accrue dans le rec. suprapatellaire.
99. a) Inflammation du sac lacrymal (sacculus lacrimalis). Infection généralement due à une sténose des voies tranénales. Localisation typique : gonflement, douleurs, rougeur et œdème sur le bord inférieur médial de l'orbite. (angle interne inférieur de la paupière). (enclume, dacryocystite)
100. b)Résultats typiques du rontgen du pneumothorax : interruption du dessin des vaisseaux et augmentation de la transparence des rayons.
101. c) Patient présentant une syncope cardiaque due à une cardiopathie structurale (sténose aortique) et une FEVG fortement réduite. Cave : syncopes convulsives (myoclonies < 15 s) =/- crise d'épilepsie. (enclume, syncope)

102. c) Patient présentant un abcès scrotal, a.e. <par un follicule pileux désenclavé. Décharge chirurgicale précoce pour éviter une complication de la gangrène de Fournier. (Enclume, Abcès scrotal, Traitement)
103. b) Patient avec suspicion de nouveau diabète sucré de type 2 > étiologie Hb1Ac. Symptômes typiques de la PNP (douleurs brûlantes, ulcère au pied). Le talon est une localisation typique de l'ulcère diabétique.
DD AOP : ulcères plutôt sur la malléole externe ou les orteils (Amboss, Diabetische Fußsyndrom/ dgn.org, Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie)
104. d) Symptômes : diarrhée chronique (>2 semaines), douleurs dans le quadrant inférieur droit : le plus probable est la maladie de Crohn
. Pancréatite DD : pas d'alcool ni de lithiase, appendicite DD : normalement sans diarrhée ou 1

Chronicisation, DD cancer du colon : rare chez les patients jeunes, DD M. Whipple : aucune manifestation extra-intestinale mentionnée.

105. c) Suspicion de fracture latérale du tiers moyen de la face avec perte de sensibilité dans la région du nerf infraorbitaire. CT pour clarification (enclume, fracture latérale du tiers moyen de la face)
106. a) Patient en état de choc répondant aux critères qSOFA. Selon les directives, la première mesure à prendre est une substitution volumique. Catécholamines si PAM <65mmHg. Antibiotiques dans la première heure suivant le diagnostic. TDM thoracique en cours (enclume, sepsis, traitement)
107. c) Le nerf radial est particulièrement menacé en cas de fracture en raison de son trajet autour de la diaphyse humérale. La clinique avec la faiblesse de l'extension est typique.
108. b) Troubles de la croissance lors d'un changement d'alimentation-> le plus souvent dus à la malabsorption. Parents de taille normale, pas de prédisposition génétique.
109. e) Douleur, ii.peau réchauffée : syndrome du compartiment le plus probablement d'origine traumatique. (Enclume, Syndrome des compartiments, Symptômes)
110. a) Symptôme principal de dysphagie : carcinome de l'œsophage. Facteurs de risque (tabac, alcool) compatibles. Estomac pâle atypique. (enclume, carcinome de l'œsophage)
111. a) Diagnostic de suspicion de cholécystite. Échographie abdominale pour clarification. (enclume, cholécystite, diagnostic)
112. c) Anévrisme de l'aorte abdominale de 4.0cm-5.4cm de diamètre : surveillance échographique tous les 6-12 mois. (awmf.org, ligne directrice BAA s3)
113. e) Diagnostic de suspicion : kératose actinique. Traitement par crème au 5-FU ou thérapie photodynamique (enclume, kératose actinique)
114. e) Les métabolites de la morphine sont éliminés par voie rénale et peuvent donc s'accumuler en cas de fonction rénale réduite. En cas de fonction rénale réduite (DFG <50 ml/min), il convient donc d'envisager une réduction de la dose à 75%. (dosing.de, Morphine / Cours de pharmacocinétique en cas d'insuffisance rénale, N.Corti)
115. b) Déclaration primaire d'une grossesse en cas d'aménorrhée. L'échographie transvaginale est également indiquée par la suite.
116. c) Patient présentant une clinique de syndrome parkinsonien. D'où le diagnostic de suspicion de démence à corps de Lewy. Hallucinations et épisodes délirants fréquents dans la LBD. (Enclume, démence à corps de Lewy)
117. b) Miosis, dépression respiratoire, somnolence : le plus probable est une intoxication aux opioïdes. Antidote : naloxone (enclume, intoxication médicamenteuse)
118. b) Leucoplasie de la muqueuse buccale : Orientation vers un examen plus approfondi et, le cas échéant, vers une excision. (Wikipedia, leucoplasie)
119. d) En cas de tamponnade péricardique, ponction de décharge en urgence. (enclume, épanchement péricardique, traitement)
120. d) Les bisphosphonates peuvent être utilisés sous traitement SERM pour ralentir l'ostéoporose. Image de Röntgen avec processus infiltratif diffus et formation de cavernes suggérée. Incidence de la tuberculose plus élevée au Burkina Faso qu'en Europe. L'anamnèse est donc plutôt suggestive de tuberculose. Une néoplasie n'est toutefois pas exclue. DD Aspergillose, Pneumocystis jirovecii : aucun indice d'immunosuppression. DD Pneumonie : pourrait indiquer une évolution plus aiguë.
122. b) Diagnostic de la lues : 1er test de recherche (TPPA) : positif 2-3 semaines après l'infection, puis positif à vie. 2. test de confirmation (FTA-ABS) : indique également une infection aiguë et une cicatrice sérologique positive. 3. nécessité d'un traitement (VDRL/RPR) : Si lues aiguës confirmées positives. -> Poursuivre le traitement médicamenteux i.m. Une application i.v. n'est nécessaire qu'en cas de neurosyphilis. (Enclume, Lues, Thérapie)
123. a) Vd. a. Méningite. Hémocultures plutôt avant la ponction de LCR selon les directives des adultes. (awmf.org, méningo-encéphalite bactérienne acquise en ambulatoire chez l'adulte)
124. c) Les taches mortuaires rouge clair sont typiques de l'intoxication au monoxyde de carbone. (enclume, monoxyde de carbone) 125.--+- Signe de Chvostek, typique de l'hypocalcémie
126. c) Traitement des blessures par morsure : Débridement important, traitement ouvert de la plaie, protection contre le tétanos, vaccination contre la rage (en cas de morsure de chien), traitement antibiotique prophylactique avec des antibiotiques à large spectre. Plutôt des antibiotiques p.o., car moins invasifs. (enclume, morsures)
127. d) Possibilités de prévention des récives en cas de dépendance à l'alcool : acamprosate, naltrexone, nalméfène, disulfiram
128. a) La première mesure à prendre est l'examen clinique et donc le toucher rectal digital.
129. b) Bronches élargies au centre, forme d'anneau de sœau. En cas de déficit en AAT, on observe typiquement un emphysème centrolobulaire. Des bronchiectasies peuvent également se produire.
- 130.+++ Hypothermie : 1ère priorité. Femme déshabillée dans un pouvoir de décembre. Abus sexuel : Possible. Femme déshabillée. Intolérance alimentaire : manger de la fondue avec une intolérance au lactose ne provoque généralement pas de syncope. Epilepsie : Possible. Paquet de benzodiazépine entamé
131. c) L'arthrite septique n'est pas nécessairement le diagnostic de suspicion primaire, mais a entraîné la mesure la plus urgente. (Enclume, Arthrite bactérienne)
132. d) En cas d'agranulocytose, le céfépime i.v. est le traitement de choix. (Doccheck, Neutropénie fébrile)
133. a) Tous les diagnostics mentionnés ici sont des causes d'hypoxémie postopératoire, mais seule l'atélectasie correspond au contrôle local et unilatéral de la respiration bruyante. En outre, l'atélectasie est une complication postopératoire relativement fréquente.

134. (*) b) Un syndrome de sevrage a été décrit en cas d'arrêt brutal des ISRS, notamment de la paroxétine. Fièvre atypique. Eventuellement syndrome sérotoninergique dans le cadre d'une remédication autonome ou d'un surdosage lors d'une tentative de suicide. (Compendium, paroxétine). DD Un syndrome grippal ne peut pas non plus être exclu sur la base des informations fournies.

seront

135. (*) Réponse non identifiable à partir de ces informations. Les réponses suggèrent le diagnostic d'un carcinome DD Cancer du côlon avec coloscopie, Hemoccult, DD CHC, la biopsie du foie n'étant pas la première étape du diagnostic. Test de l'antigène de l'hépatite C inutile... Au mieux a)
136. (*) Réponse non clairement identifiable à partir des informations.
137. (*) le plus souvent b) DD angioedème. Sécuriser les voies respiratoires selon le schéma ABCDE 1ère priorité. CAVE : DD angioedème héréditaire : antihistaminiques et glucocorticoïdes non indiqués. Options thérapeutiques : d) et e). Antibiotiques à large spectre également indiqués le plus rapidement possible en cas de leucocytose sous immunosuppression.
138. (*) b, d) Les deux causes ont une forte influence sur le diagnostic/le traitement. En cas de méningisme, il convient d'exclure une méningite bactérienne. Les symptômes ne sont toutefois pas typiques de la méningite. Attention : une thrombose des sinus veineux peut également se manifester par un méningisme. La thrombose de la veine sinusale est une complication redoutée de l'otite moyenne aiguë !

2020 Réponses

- b) Paralysie trochléenne entraînant la perte du muscle oblique supérieur (Fct : rotation interne, abduction et abaissement du globe oculaire en adduction) avec par conséquent une double image très forte lors du regard vers le bas du nez (enclume, syndrome des nerfs crâniens).
- c) Classification des fractures médianes du col du fémur en fractures en adduction ou en abduction 1:1f. Dans la première, triade typique de la rotation externe (<par traction musculaire des muscles glutei sur le grand trochanter), de la déformation de la jambe et de la douleur lors du mouvement de l'articulation de la hanche. Dans ce dernier cas, cliniquement, il n'y a souvent que des douleurs à la pression et à la compression (DocCheck, fracture du col du fémur)
- b) Des douleurs lombaires à l'effort avec irradiation dans les jambes et diminution de la distance de marche sont a.e. en faveur d'une claudication intermittente du rachis en cas de sténose du canal rachidien. La méthode diagnostique de choix est l'IRM du rachis lombaire (enclume, sténose dégénérative du canal rachidien).
- e) Si le statut vaccinal n'est pas clair, la vaccination antitétanique doit être mise à jour. En outre, l'extrémité du membre doit être immobilisée, surélevée et la plaie désinfectée. En l'absence de réaction locale significative ou d'effet toxique systémique dans les 4 à 6 premières heures, le patient peut être libéré. L'administration d'antitoxines n'est généralement pas indiquée et ne doit se faire qu'en accord avec le centre antipoison (Bertheau, S. et al. Morsure de serpent. MMW - Progrès de la médecine 159, 45 (2017))
- b) Un traumatisme thoracique contondant peut entraîner une fibrillation ventriculaire pendant la phase vulnérable du rythme cardiaque (commotio cordis). C'est l'une des principales causes d'arrêt cardiaque dans le sport (Klingberg, K. et al., Restart the heart).
- e) L'angio-oedème non allergique le plus fréquent est causé par les inhibiteurs de l'ECA et peut survenir après une période de latence de plusieurs années. Cependant, l'angio-oedème est également un effet secondaire possible des inhibiteurs des récepteurs ATI. (Pharmazeutische Zeitung, effets secondaires des inhibiteurs de l'ECA)
- a.e. d) Une dose de rayonnement inférieure à 100mSv est considérée comme faible. L'exposition annuelle aux radiations en Suisse est d'environ 4 mSv (OFSP). En dessous de 200 mSv, il ne faut pas s'attendre à des symptômes aigus, mais des modifications du patrimoine génétique peuvent apparaître à long terme (Wikipedia, maladie due aux radiations).
- d) L'hypothyroïdie provoque souvent des symptômes de dépression. Il convient donc de déterminer la numération formule sanguine, le taux de TSH et les taux d'électrolytes, de vitamine B12 et d'acide folique de routine. (Manuel MSD, Trouble dépressif)
- a) Occasionnellement, des lésions rénales provoquent des analgésiques (p. ex. paracétamol, ibuprofène, diclofénac), des antibiotiques (p. ex. aminoglycosides), des produits chimiothérapeutiques, des produits de contraste iodés (intemistes dans le réseau : insuffisants rénaux).
- e) En cas de suspicion de traumatisme par inhalation ou de brûlure dans la région cranio-cervicale : Intubation immédiate en raison du risque de gonflement secondaire des voies respiratoires (enclume, brûlure).
- d) Un examen médico-légal et gynécologique complet, tenant compte des aspects médico-légaux tels que la documentation des résultats et la conservation des traces, doit être possible indépendamment d'une plainte pénale (brochure 'Examen des adultes après des violences sexuelles' de la SSML, édition mars 2015).
- c) Les diurétiques thiazidiques peuvent augmenter la concentration sérique d'acide urique en raison d'une diminution de la clairance de l'acide urique et sont donc recommandés chez les patients souffrant d'hyperuricémie/de goutte (Compendium).
- a) L'évolution et la perte de poids sont plutôt en faveur d'un carcinome (et l'absence de lésion n'est pas forcément en faveur d'une lésion, des parties nécrotiques d'un carcinome peuvent se produire). La nécrose et la dyspnée peuvent aussi être en faveur d'une LE, mais seraient plus aiguës. La nécrose n'est pas typique de la sarcoïdose. PCP improbable car aucune immunosuppression n'est mentionnée.
- c) Syndrome d'Ortner (parésie récurrente du côté gauche) comme conséquence possible d'un traumatisme de décélération avec formation d'un anévrisme aortique (Matussek, VK et al. Laryngorhinootologie 2004)
- e) Clinique évocatrice de mastite puerpérale. Le traitement consiste à vider régulièrement les seins, à les réchauffer avant de les vider et à les irradier après les avoir vidés (enclume, post-partum).

16. d) Les symptômes sont typiques du syndrome du canal carpien. Le diagnostic repose sur l'électroneurographie, qui révèle une diminution de la vitesse de conduction nerveuse du nerf médian, signe de démyélinisation.
17. a) L'assuré a droit à un reclassement dans une nouvelle activité lucrative si le reclassement est nécessaire en raison de l'invalidité et qu'il permet vraisemblablement de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain (art. 17 LAI). L'office AI prend ces mesures sans délai [...] (art 18 LAI).
18. c) Procédure de base en cas de méningite Vd.a. : hémocultures -> glucocorticoïdes -> antibiothérapie calculée -> Schadel-CT-> Ponction du LCR (enclume, méningite)
19. e) Vd. a. Osgood-Schlatter. Le diagnostic est posé sur la base des résultats caractéristiques et, le cas échéant, d'une radiographie du genou.